



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

PANDUAN MANAJEMEN LOGISTIK FARMASI TAHUN 2026

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PENGESAHAN

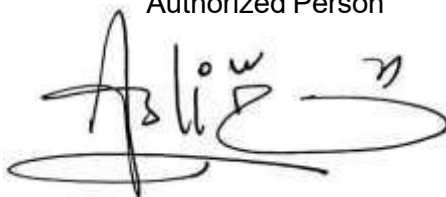
Panduan Manajemen Logistik Farmasi
Rumah Sakit Prima Husada
Tahun 2026

Disusun oleh:
Kepala Instalasi Farmasi



(apt. Laili Choirul Umma, S. Farm)

Disetujui oleh:
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP)

Ditetapkan oleh:
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(Ns. Heni Indra Wulansari, S. Kep. M. Kep)

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP

PENYUSUN

1. Ns. Heni Indra Wulansari, S. Kep. M. Kep
2. apt. Laili Choirul Umma, S.Farm
3. apt. Ramadhan Rizki Putranto, S.Farm
4. apt. Shinta Aprillia Rizky, S.Farm
5. apt. Laili Choirul Umma, S.Farm
6. apt. Miftakhul Rohmah Putri, S.Farm
7. apt. Yolanda Riskawasianda Y, S. Farm
8. apt. Nur Intan Permatasari , S.Farm
9. apt. Lilis Ika K, S. Farm
10. apt. Dita Nurul Aini, S.Farm
11. apt. Ledyna Astri O, S. Farm
12. apt. Permata Sari Pratiwi, S. Farm
13. apt. Rohmah Madya Ayu Fitriana, S.Farm
14. Sinta Dewi Novitasari, A.Md.Farm
15. Ayu Indra Irmia, Amd. Farm
16. Siti Alisia Arti, A.Md. Farm
17. Windi Kartika, A.Md.Farm
18. Siti Nasiha, A.Md.Farm
19. Tiffani Andika, A.Md.Farm
20. Agung Prabowo, A.Md.Farm
21. Amilia Dwi Lismawati, A.Md.Farm
22. Widiya Fatmawati
23. Olivia Febriani, S.Farm
24. Sintia Anggriani, A.Md.Kes
25. Khopnia, A.Md.Farm
26. Lolita Indriani Putri, A.Md.Farm
27. Ivan Fadilla AMd. Farm
28. Umus Salamah, AMd.Farm
29. Ayutya Helgayanti, S.Farm
30. Khoirunnisai, S.Farm
31. Niken Dewi Hastuti, S.Farm
32. Sheila Luthfi Sabrina, A.Md.Farm
33. Alfian Setyadi
34. Chela Meidita Elsa Putri
35. Khoirun Najwa Abidah, A.Md.Farm
36. Anisah Kurniawati, A.Md.Farm
37. Adelia Maharani, A.Md.Farm
38. Ardhita Rahma Wiji Lestari, A.Md.Farm
39. Chessia Jeseloy Cahya Putri, A.Md.Farm
40. Della Anasya Nandita, A.Md.Farm
41. Intan Larasati, A.Md.Farm
42. Putri Oktavia Larasati, A.Md.Farm
43. Dyah Rahmah Fauziyah, A.Md.Farm
44. Salsabila Amalia, A.Md.Farm
45. Shofiyah Nisrina Dewi, A.Md.Farm

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Panduan Manajemen Logistik Instalasi Farmasi dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. PrimaHusada. Panduan Manajemen Logistik Farmasi Rumah Sakit ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2026 meliputi kegiatan perencanaan, pengimplementasian dan pengontrolan secara efektif dan efisien terhadap arus barang yang masuk dan keluar dalam pelayanan di rumah sakit.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Panduan Manajemen Logistik Farmasi Rumah Sakit mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Pasuruan, 02 Februari 2026
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S. Kep. M. Kep

DAFTAR ISI

JUDUL i

LEMBAR PENGESAHAN..... ii

KATA PENGANTAR iii

TIM PENYUSUN..... iv

DAFTAR ISI v

PERATURAN DIREKTUR 1

BAB I

PENDAHULUAN 11

1.1 LATAR BELAKANG 11

1.2 TUJUAN 12

1.2.1 TUJUAN UMUM..... 12

1.2.2 TUJUAN KHUSUS 12

BAB II

TATA LAKSANA 13

2.1 LOGISTIK DAN MANAJEMEN LOGISTIK..... 13

2.2 SISTEM LOGISTIK..... 14

2.3 LOGISTIK RUMAH SAKIT 14

2.4 SIKLUS MANAJEMEN LOGISTIK RUMAH SAKIT 14

2.4.1 PEMILIHAN 15

2.4.2 SELEKSI PEMASOK / SUPPLIER 15

2.4.3 PERENCANAAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN..... 16

2.4.4 PENGANGGARAN 19

2.4.5 PENGADAAN 19

2.4.6 PENERIMAAN 20

2.4.7 PENYIMPANAN..... 20

2.4.8 PENDISTRIBUSIAN..... 21

2.4.9 PEMANFAATAN 22

2.4.10 PEMELIHAAN 22

2.4.11 PENGHAPUSAN 23

2.4.12 PENGENDALIAN 24

2.4.13 JENIS PERBEKALAN FARMASI YANG BERISIKO 24

2.4.14 ALUR COLD CHAIN PRODUCT..... 26

2.4.15 COLD CHAIN PRODUCT MANAGEMENT 27

BAB III

FAKTOR YANG TERKAIT LOGISTIK 29

3.1 FAKTOR INPUT..... 29

3.1.1 SUMBER DAYA MANUSIA..... 29

3.1.2 DANA..... 29

3.1.3 FASILITAS DAN MESIN..... 30

3.1.4 PROSEDUR 30

3.1.5 KEBERADAAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI 31

3.1.6 SUPPLIER 31

3.2 FAKTOR PROSES 31

3.2.1 PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENETAPAN LOGISTIK 31

3.2.2 PELAKSANAAN PENGADAAN LOGISTIK..... 31

3.2.3 PELAKSANAAN PENNYIMPANAN LOGISTIK..... 32

3.2.4 PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK 33

3.2.5 PELAKSANAAN PEMELIHARAAN LOGISTIK 33

3.2.6 PENGHAPUSAN LOGISTIK 34

3.2.7 PENGENDALIAN LOGISTIK..... 34

3.3 FAKTOR OUTPUT..... 35

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI 36

4.1 MONITORING 36

4.2 EVALUASI 36

BAB V

PENUTUP 37

Lampiran 38

Daftar Pustaka 39

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 117/RSPHS/I-PER/DIR/II/2026**

TENTANG

**PANDUAN MANAJEMEN LOGISTIK FARMASI
DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perlu menjamin aksesibilitas obat yang aman, berkhasiat dan bermutu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Panduan Manajemen Logistik Farmasi
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Standar Cara Distribusi Obat Yang Baik
6. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 059.1/RSPHS/I-KEP/DIR/II/2025 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo;
7. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG
PANDUAN MANAJEMEN LOGISTIK FARMASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
- (2) Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
- (3) Bahan Medis Habis Pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Instalasi Farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
- (5) Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
- (6) Apoteker harus terdaftar di Kementerian Kesehatan dan telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) Seumur Hidup dan memiliki Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA).
- (7) Apoteker melakukan supervisi sesuai dengan penugasannya.
- (8) Tenaga Vokasi Farmasi adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi dan Ahli Madya Farmasi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian;
- b. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian;
- c. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*);
- d. Mengarahkan Penggunaan obat yang aman dan meminimalkan resiko kesalahan penggunaan obat sesuai peraturan perundang undangan.

BAB III

STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN

Pasal 3

Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit meliputi :

- a. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
- b. Pelayanan farmasi klinis.

BAB IV

PENGELOLAAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN BAHANMEDIS HABIS PAKAI

Pasal 4

- (1) Penentuan tingkat risiko obat-obatan, perbekalan medis, serta peralatan medis disertai bagan alur rantai perbekalannya.
- (2) Penetapan titik paling berisiko dalam bagan alur rantai perbekalan.
- (3) Penetapan upaya mitigasi risiko dalam rantai perbekalan.

Pasal 5

Perencanaan

- (1) Perencanaan kebutuhan obat sesuai pelaporan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) pada aplikasi e-Monev
- (2) Perencanaan dilakukan untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode konsumsi.
- (3) Dasar perhitungan perencanaan setahun menggunakan data laporan penjualan tahun sebelumnya (bisa 1-3 tahun) dengan penambahan *Buffer stock* sebanyak 30%, sesuai ketentuan Dinas kesehatan dan perundangan yang berlaku
- (4) Revisi Rencana Kebutuhan Obat (RKO) E-Monev dilakukan pada agenda perubahan di tengah tahun
- (5) Perencanaan yang dilakukan oleh Depo untuk permintaan barang setiap hari menggunakan rumus $RPO + \text{Buffer } 10\%$
- (6) Perencanaan dilakukan dengan memperhitungkan *Always Better Control* (ABC), *Vital, Essential & NonEssential* (VEN), *Evidence Base Medicine* (EBM), pola konsumsi dan epidemiologi penyakit

Pasal 6

Pemilihan Produk farmasi

- (1) Pemilihan sediaan farmasi pada Formularium Rumah Sakit disusun mengacu kepada Formularium Nasional.
- (2) Formularium Rumah Sakit merupakan daftar obat yang disusun Tim Farmasi dan Terapi yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) *Review* formularium dilakukan satu tahun sekali berdasarkan informasi tentang keamanan dan efektivitas.
- (4) Obat lama/baru dikeluarkan dari formularium rumah sakit apabila risiko ketidakamanan obat baru lebih dari efikasinya.
- (5) Instalasi farmasi melakukan pencatatan untuk memantau kepatuhan terhadap formularium baik dari persediaan ataupun penggunaannya.
- (6) Adanya suatu mekanisme untuk mengatasi ketidaktersediaan obat pada peresepan obat formularium dan non-formularium.
- (7) Rumah Sakit memiliki sumber informasi obat yang tepat, terkini dan selalu tersedia bagi semua yang terlibat dalam penggunaan obat.

Pasal 7

Pengadaan

- (1) Syarat vendor ;
 - a) Pengadaan harus berasal dari jalur resmi dan terverifikasi dengan mempertimbangkan pemilihan pemasok dan metode pengadaan.
 - b) Memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan BPOM.
 - c) Sistem pengadaan harus berdasarkan kontrak termasuk hak akses untuk meninjau

-
- ke tempat penyimpanan dan transportasi sewaktu-waktu.
- d) Manajemen rantai pengadaan harus menjamin keamanan, mutu, manfaat dan khasiat dengan adanya garansi keaslian obat, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - e) Sistem kebijakan retur yang mempermudah pengadaan dalam proses pengembalian produk untuk kategori produk rusak/cacat ataupun produk yang memiliki ED dekat.
- (2) Prosedur pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, vaksin, reagen, gas medis, bahan berbahaya dan beracun (B3). Jika kekosongan terjadi di Gudang Farmasi;
- a) Periksa sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, vaksin, serta bahan berbahaya dan beracun (B3) di gudang farmasi.
 - b) Catat stok yang mencapai stok minimal dan yang mengalami kekosongan.
 - c) Lakukan telusur oleh Apoteker Gudang Farmasi.
 - d) Lihat SPO Permintaan dan Distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, vaksin, reagen, gas medis, serta bahan berbahaya dan beracun (B3).
 - e) Catat di formulir kekosongan
- (3) Prosedur pengadaan sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, BMHP dan Reagen. Jika kekosongan terjadi di Distributor terkait;
- a) Periksa stok sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, vaksin, serta bahan berbahaya dan beracun (B3) di gudang farmasi.
 - b) Catat stok yang mencapai stok minimal dan yang mengalami kekosongan.
 - c) Catat di formulir kekosongan.
 - d) Laporkan kepada Kepala Instalasi Farmasi tentang terjadinya kekosongan distributor.
 - e) Lakukan telusur oleh Kepala Instalasi Farmasi dan saran substitusi serta rencana tindak lanjut.
 - f) Mintakan persetujuan Direktur RS tembusan Apoteker Pengadaan Farmasi PT.
 - g) Lakukan telusur oleh Apoteker Pengadaan Farmasi PT.
 - h) Hubungi distributor terkait dan mintakan surat pemberitahuan kosong distributor
 - i) Lakukan tindak lanjut oleh Apoteker Pengadaan Farmasi PT sesuai saran Kepala Instalasi Farmasi, jika terdapat pengalihan distributor yang menyediakan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, vaksin, serta bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan komposisi sama namun merk berbeda atau terdapat pengganti sediaan lain.
 - j) Lakukan tindak lanjut oleh Apoteker Pengadaan Farmasi PT sesuai saran Kepala Instalasi Farmasi, jika terdapat pengalihan distributor yang menyediakan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, vaksin, serta bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan komposisi sama namun merk berbeda atau terdapat pengganti sediaan lain.
 - k) Kirim surat pemberitahuan kekosongan dan tindak lanjut substitusi tembusan Direktur RS.
 - l) Sebarkan kepada Depo Farmasi, Depo IGD/IKO dan PPA.
- (4) Prosedur pengadaan sediaan farmasi, jika terjadi kekosongan karena peresepan di luar formularium;
- a) Lakukan kajian farmasi klinis di CPPT rekam medis pasien.
 - b) Lakukan pengecekan advice DPJP dengan master data, monitoring stok di SIMRS dan formularium rumah sakit.
 - c) Lakukan konsultasi substitusi dengan DPJP terkait advice obat di luar formularium.
 - d) Konsultasikan kepada Kepala Instalasi Farmasi jika DPJP tetap memberikan advice

- obat di luar formularium, konsultasikan.
- e) Konfirmasi kepada Kepala Instalasi Farmasi terkait dengan kondisi pasien, diagnosa dan cara bayar pasien
 - f) Konsultasikan kepada Kepala Bidang Penunjang Medik dan Direktur RS.
 - g) Cari informasi terkait dengan ketersediaan dan harga obat tersebut.
 - h) Laporkan informasi yang diperoleh kepada Apoteker Pengadaan Farmasi PT.
 - i) Konsultasikan kepada Direktur PT Disa Prima Medika.
 - j) Buat master barang obat baru dari Keuangan PT Disa Prima Medika
 - k) Buat surat pesanan dari Apoteker Gudang farmasi.
 - l) Pengadaan PT melakukan cek ulang terkait jumlah Surat Pesanan yang di buat oleh Apoteker Gudang Farmasi.
 - m) Pengadaan PT melakukan release Surat Permintaan pada billing SIMRS.
 - n) Direktur PT melakukan approve Surat Permintaan yang telah di seleksi oleh Pengadaan Farmasi PT.
 - o) Kepala Instalasi menandatangani Surat Pesanan.
 - p) Bawa surat pesanan dan resep manual untuk pembelian obat.
 - q) Tulis di form kekosongan obat dan form permintaan obat diluar formularium oleh petugas farmasi dan berikan kepada Apoteker sebagai bukti dokumentasi.
 - r) Jika terjadi kasus berulang maka meminta DPJP untuk pengajuan obat baru
- (5) Prosedur pengadaan sediaan farmasi, jika kekosongan terjadi karena peresepan *me-too*, maka:
- a) Konfirmasi ke dokter terkait bahwa tidak ada obat yang diminta di Depo Farmasi dan Depo IGD/IKO dan berikan saran substitusinya.
 - b) Jika dokter setuju, maka ganti obat sesuai saran substitusi dan konfirmasi ke perawat ruangan terkait.
 - c) Jika dokter tidak setuju dengan saran substitusi maka lihat poin no (3d) di atas.
 - d) Catat di form kekosongan obat dan laporkan ke Apoteker
 - e) Catat setiap komunikasi ke dokter di form komunikasi dokter dan mintakan paraf ke dokter terkait 1x24 jam
 - f) Jika terjadi Mutasi Barang Antar Rumah Sakit dalam naungan PT Disa Prima Medika;
 - g) Lakukan konfirmasi ke petugas gudang farmasi Rumah Sakit tujuan jika melakukan permintaan pembelian antar rumah sakit.
 - h) Buat surat pesanan dari Gudang farmasi dan bukti permintaan pada Form Pembelian obat antar Rumah Sakit mengetahui Kepala Instalasi Farmasi.
 - i) Input penerimaan barang pada SIMRS berdasarkan pembelian antar rumah sakit.
 - j) Serahkan Nota Pembelian pada Keuangan RS.

Pasal 8.

Penerimaan

- (1) Penerimaan harus menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima.
- (2) Penyerahan obat (*Hand Over*) harus dilakukan verifikasi kesesuaian meliputi benar jenis, benar jumlah, benar harga, benar ED, benar nomor *batch*, kondisi fisik dan benar dokumen.
- (3) Dilakukan Cek ulang saat memasukkan data penerimaan kedalam SIMRS dan secara fisik berikan tanda centang pada Faktur.

Pasal 9

Penyimpanan

- (1) Penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai harus baik, benar dan aman serta menjamin kualitas meliputi persyaratan stabilitas suhu temperatur ruangan dipelihara pada suhu 15°C - 25°C, temperatur almari pendingin dipelihara pada suhu 2°C - 8°C, temperatur almari pembeku dipelihara pada suhu -15°C sampai dengan -25°C dan keamanan penyimpanan obat, sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi dan penggolongan jenis.
- (2) Pencegahan kehilangan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dilakukan secara internal dan eksternal.
- (3) Sediaan farmasi yang penampilan dan penamaan yang mirip *Look a like Sound a like* (LASA) tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus yakni stiker LASA pada obat untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat. Pada obat LASA, label obat dosis rendah berwarna hijau, label dosis sedang berwarna kuning dan label dosis tinggi berwarna biru. Penyimpanan pada rak harus tertempel stiker LASA.
- (4) Penyimpanan obat resiko tinggi (*high risk*) di Instalasi Farmasi diberi stiker "*High Alert*" dan elektrolit konsentrat diberi stiker "*High Alert*", "Encerkan" dan "LASA". Obat disimpan secara terpisah, tersorot lampu dan dibatasi dengan label berwarna merah. Penyimpanan pada rak *High Alert* harus tertempel stiker *High Alert*.
- (5) Elektrolit konsentrat dilarang disimpan di unit perawatan kecuali bila dibutuhkan secara klinis dengan tujuan dapat segera dipakai untuk memenuhi kebutuhan darurat.
- (6) Elektrolit konsentrat yang disimpan pada unit perawatan pasien harus diletakkan pada *box/trolley/kit emergency* dengan segel pengaman untuk menghindari kesalahan, harus diberi label yang jelas dan disimpan pada area yang dibatasi ketat (*restricted*) untuk mencegah penatalaksanaan yang kurang hati-hati.
- (7) Penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang disimpan diluar Instalasi Farmasi (*box emergency, kit emergency* dan *trolley emergency*) dikelola dan dimonitor oleh Instalasi Farmasi dengan supervisi Apoteker.
- (8) Obat narkotika dan psikotropika disimpan yang baik, benar dan aman sesuai peraturan perundang-undangan.
- (9) Tempat penyimpanan narkotika dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain narkotika.
- (10) Tempat penyimpanan psikotropika dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain psikotropika.
- (11) Lemari khusus narkotika dan psikotropika harus terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda, diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum, kunci lemari khusus dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab/Apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan.
- (12) Penyimpanan reagen esensial disimpan dalam suatu lemari dengan suhu penyimpanan sesuai yang disarankan oleh produsen pada temperatur almari pendingin dipelihara pada suhu 2°C - 8°C, dan temperatur almari pembeku dipelihara pada suhu -15°C sampai dengan -25°C, semua reagen esensial disimpan dan diberi label.
- (13) Bahan berbahaya dan beracun (B3) disimpan dalam tempat khusus dan diberi label B3 sesuai dengan klasifikasi. Bahan kimia yang terbuka diberi label secara jelas.
- (14) Obat oral, injeksi, serta produk nutrisi enteral maupun parenteral disimpan dengan baik dan benar sesuai dengan instruksi penyimpanan yang tertera dari produsen atau vendor.

Pasal 10
Gas medis

Penyimpanan gas medis rumah sakit berada di bawah pengawasan dan pengelolaan Instalasi Farmasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Obat hibah

- (1) Obat yang diberi oleh pemerintah (obat hibah) di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo adalah obat TBC, obat HIV (ARV), vaksin, program KB yang disimpan dengan baik, benar dan aman sesuai dengan stabilitasnya.
- (2) Obat tidak bertuan yang kembali ke Gudang maka masuk dalam gudang statusnya sebagai obat Hibah di dalam SIMRS
- (3) Obat dan alkes untuk program KB dikirim oleh BKKBN daerah setempat
- (4) Obat HIV (ARV) diberikan oleh Dinas Kesehatan sesuai kebutuhan pasien dan permintaan dari Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
- (5) Vaksin Program Pemerintah diberi dari Dinas Kesehatan setempat bisa melalui Puskesmas wilayah setempat
- (6) Obat dan alkes untuk KLB, Epidemi dan kasus tertentu didapatkan dari Dinas Kesehatan setempat
- (7) Laporan disampaikan kepada Kemenkes melalui *website* sesuai yang telah ditetapkan oleh kemenkes secara periodik.

Pasal 12
Obat Sitostatika

Tidak terdapat obat sitostatik / kemoterapi (radioaktif), obat yang digunakan khusus untuk penelitian dan bahan baku obat di RS Prima Husada Sukorejo.

Pasal 13
Produk Farmasi Hemodialisa

Obat, Bahan Medis Habis Pakai dan alat kesehatan untuk pelayanan Hemodialisa disediakan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.

Pasal 14
Pelabelan obat

- (1) Pelabelan obat harus dilakukan saat penyimpanan untuk mewaspadai obat-obat *High Alert* dan LASA
- (2) Tiap rak diberi label tulisan sesuai nama Obat dengan huruf yang jelas dan *Fonts* yang bisa dibaca jarak 1 M
- (3) Penamaan LASA disesuaikan dengan aturan *Tall Man Lettering* dan penataan secara alfabetis

Pasal 15
Pendistribusian

- (1) Pendistribusian Produk farmasi sesuai list permintaan barang dari Depo central dan Depo IGD/IKO pada H-1 malam hari pukul 24.00 untuk penyiapan kebutuhan pagi hari. Kebutuhan sore dan malam permintaan diterima oleh Gudang pada siang hari sebelum

shift petugas gudang farmasi berakhir.

- (2) Perhitungan perencanaan permintaan produk farmasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pendistribusian Produk farmasi sesuai list permintaan barang yang dikirim dilakukan 3x seminggu (senin, rabu, jumat)
- (4) Permintaan BMHP dari unit dilakukan pada hari kamis, penyiapan dilakukan gudang farmasi pada hari sabtu
- (5) Penyerahan BMHP Unit dilakukan setiap hari Senin.
- (6) Penyerahan barang (*Hand Over*) harus dilakukan verifikasi kesesuaian meliputi benar jenis, benar jumlah, benar ED, benar nomor *batch* dan benar dokumen.
- (7) Pendistribusian ke *Box Emergency* menjadi tanggung jawab Depo central dan Depo IGD/IKO
- (8) Pendistribusian produk farmasi ke kamar Operasi menjadi tanggung jawab Depo IGD/IKO
- (9) Produk farmasi reagen laboratorium segera setelah diterima oleh Gudang farmasi didistribusikan ke Laboratorium.

Pasal 16

Pengelolaan Obat *Near Expired Date*

- (1) Produk farmasi yang *near expired date* kurang dari 6 bulan dilakukan pemantauan dan evaluasi setiap bulan.
- (2) Dilakukan permintaan retur ke vendor untuk produk-produk farmasi yang kurang dari 6 bulan dan *High alert slow moving* terutama yang ditempatkan di box/trolley/lemari Emergency
- (3) Obat oral dan topikal generik yang *near expired date* ditindak lanjuti dengan berkoordinasi dengan Kepala Bidang, Komite medik dan DPJP sesuai prosedur yang berlaku.

Pasal 17

Retur produk Farmasi

- (1) Prosedur retur dilakukan sesuai perjanjian dengan pihak ketiga atau vendor
- (2) Barang yang diretur ketika penerimaan barang dari vendor antara lain:
 - a) Kemasan bentuk berubah seperti penyok/rusak
 - b) Antara dokumen faktur dengan barang fisik tidak sesuai
 - c) Penyimpanan saat transportasi tidak sesuai standart
 - d) Barang dengan *Expired Date* dibawah 1 tahun

Pasal 18

Penarikan dan Pemusnahan

- (1) Penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar/ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM (*mandatory recall*) atau berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik Izin edar (*voluntary recall*)
- (2) Penarikan Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai dilakukan terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh Menteri.
- (3) Pemusnahan untuk sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bila produk tidak memenuhi persyaratan mutu, telah kedaluwarsa, rusak, tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan/atau dicabut izin edarnya.

Pasal 19
Pengendalian

- (1) Pengendalian dilakukan terhadap jenis, jumlah persediaan, penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Pengendalian penggunaan dilakukan oleh Apoteker Gudang Farmasi.
- (2) Petugas gudang farmasi wajib melakukan *stock opname* di hari sabtu terakhir setiap bulan atau dilakukan 1 bulan sekali.
- (3) Penanggung jawab masing-masing Depo melakukan *stock opname* di sabtu terakhir setiap bulan atau dilakukan 1 bulan sekali.
- (4) *Stock opname* akan dilakukan *cross chek* validitasnya oleh auditor PT Disa Prima Media.
- (5) Pengawasan dan Penggantian *box/trolley/kit emergency* dilakukan dalam waktu kurang dari 5 menit setelah ada laporan dari unit, penggantian *box/trolley/kit/lemari emergency* dilakukan oleh Depo central dan Depo IGD/IKO.

Pasal 20
Administrasi – Pencatatan Pelaporan .

- (1) Pencatatan dan pelaporan terhadap kegiatan pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, pendistribusian, pengendalian persediaan, pengembalian, pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dilakukan setiap hari.
- (2) Pelaporan dibuat secara periodik yang dilakukan gudang farmasi dalam periode waktu tertentu (bulanan, triwulanan atau tahunan).
- (3) Kepala Instalasi Farmasi (Apoteker) melakukan pelaporan penerimaan dan pengeluaran sediaan farmasi narkotika dan psikotropika melalui SIPNAP secara periodik setiap bulan kepada Kementerian Kesehatan.
- (4) Pencatatan dilakukan antara lain :
 - a) Pengisian Kartu Stok
 - b) Penerimaan
 - c) Pendistribusian atau pengeluaran
 - d) Retur
 - e) Rekap faktur
 - f) Evaluasi vendor
 - g) Rekap *Obat Near Expired Date* dan lain-lain sesuai yang dibutuhkan

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 21

Setiap Tenaga Kefarmasian yang menyelenggarakan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit wajib mengikuti Standar Pelayanan Kefarmasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur ini.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku, Peraturan

Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 2148.145/RSPHS/I-PER/DIR/IV/2022
tentang Manajemen Logistik Farmasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 02 Februari 2026
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S. Kep. M. Kep

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR 117/RSPHS/I-PER/DIR/II/2026
TENTANG PANDUAN MANAJEMEN
LOGISTIK FARMASI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit memerlukan manajemen yang baik agar dapat mengatur semua komponen yang terdapat di dalamnya sehingga terjadi kesinergisan satu sama lainnya. Salah satu manajemen yang terdapat pada suatu rumah sakit yang memegang peran penting dalam kelangsungan proses pelayanan, baik pelayanan internal maupun eksternal rumah sakit adalah manajemen logistik. Manajemen logistik merupakan bagian dari *supply chain management* yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengimplementasian dan pengontrolan secara efektif dan efisien terhadap arus barang yang masuk dan keluar serta penyimpanan barang, jasa, serta informasi terkait antara titik asal dengan titik konsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan (Hendayani, 2011).

Manajemen adalah Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Ratnasari, 2019). Keberhasilan organisasi mencapai tujuan didukung oleh pengelolaan faktor-faktor antara lain *Man, Money, Machine, Method* dan *Material*. Pengelolaan yang seimbang dan baik dari kelima faktor tersebut akan memberikan kepuasan kepada *customer*. Logistik merupakan suatu proses perencanaan, implementasi, pengendalian dan pengelolaan berbagai komponen yang meliputi bahan baku, jasa, informasi, komunikasi, dan arus modal. Tidak hanya perencanaan saja, logistik juga termasuk pembelian, transportasi, penawaran dan perawatan (Gattorna dan Walters, 2011).

Bagian logistik farmasi adalah bagian dari unit pelayanan farmasi rumah sakit yang berfungsi sebagai sarana pengelola perbekalan farmasi yang digunakan di rumah sakit. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit, pengelolaan perbekalan farmasi merupakan suatu siklus kegiatan dimulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan. Tujuan dari pengelolaan perbekalan farmasi adalah mengelola perbekalan farmasi yang efektif dan efisien, menerapkan farmakoekonomi dalam pelayanan, meningkatkan kompetensi tenaga farmasi, mewujudkan Sistem informasi manajemen berdaya guna dan tepat guna, serta melaksanakan pengendalian mutu pelayanan.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Memberikan pemahaman bagi petugas tentang pengelolaan kebutuhan logistik farmasi di Gudang Farmasi Rumah Sakit Prima Husada.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi ketersediaan logistik farmasi di Rumah Sakit Prima Husada.
2. Mengetahui gambaran input (sumber daya manusia, dana, fasilitas, prosedur, struktur dan *supplier*) dalam sistem logistik farmasi di Rumah Sakit Prima Husada.
3. Mengetahui gambaran proses (perencanaan dan penetapan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan dan pengendalian) dalam sistem logistik farmasi di Rumah Sakit Prima Husada.
4. Mengetahui gambaran output (ketersediaan) dalam sistem logistik farmasi di Rumah Sakit Prima Husada.

BAB II
TATA LAKSANA

2.1 Logistik dan Manajemen Logistik

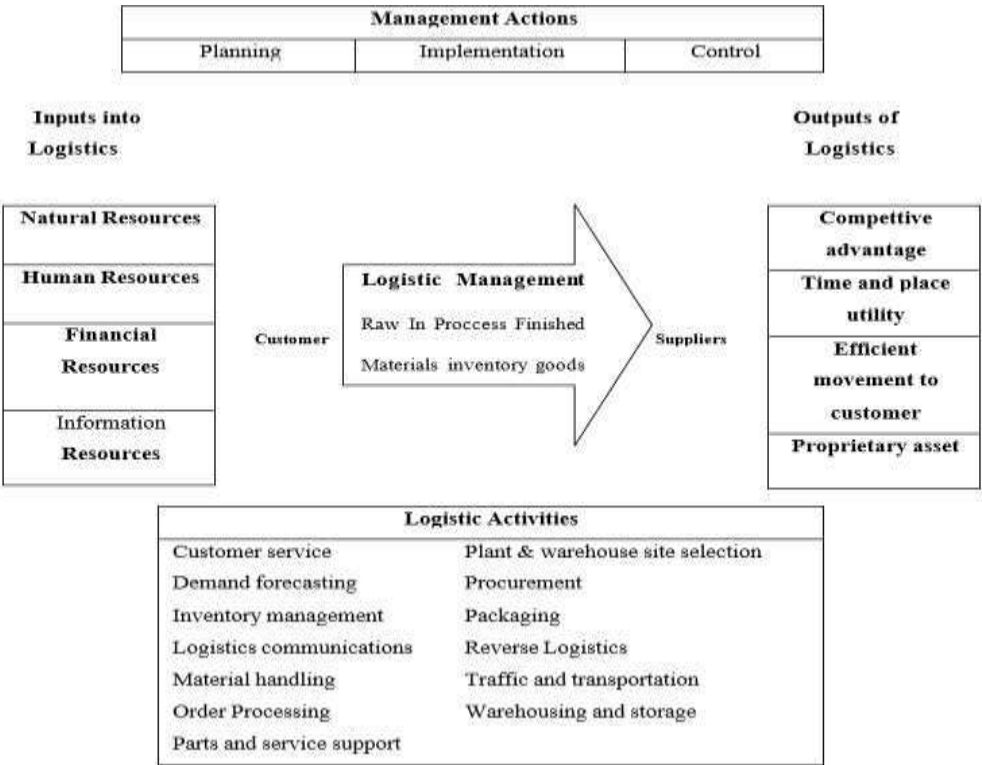
Logistik berasal dari bahasa Yunani “logistikos” yang berarti pandai dalam merumuskan perkiraan-perkiraan. Logistik adalah ilmu dan seni serta proses yang dilakukan untuk memastikan material yang akan digunakan telah tersedia melalui perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan dan penghapusan (Rahmiyati & Irianto, 2021)

Pengertian lain dari logistik menurut Hendayani (2011) adalah proses dari pengelolaan secara strategis dalam usaha perolehan, pergerakan dan penyimpanan bagian material dan persediaan akhir, juga berhubungan dengan arus informasi, melalui organisasi dan jalur pemasarannya dalam beberapa cara untuk mendapatkan keuntungan tertentu di masa depan yang maksimal melalui ongkos pemenuhan pemesanan yang efektif.

Manajemen logistik merupakan bagian dari *supply chain managemet* yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengimpelementasian dan pengontrolan secara efektif dan efisien terhadap arus barang yang masuk dan keluar serta penyimpanan barang, jasa, serta informasi terkait antara titik asal dengan titik konsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan (Hendayani, 2011). Pengertian lain dari manajemen logistik adalah bagian dari manajemen rantai pasokan yang merencanakan, mengimplementasikan dan mengendalikan aliran dan penyimpanan yang efisien dan efektif dari aliran dan penyimpanan barang, jasa dan informasi terkait antara titik asal dan titik konsumsi untuk memenuhi persyaratan pelanggan (Garcia, Hernandez, & Hernandez (2013).

2.2 Sistem Logistik

Komponen manajemen logistik berupa input dalam logistik (sumber natural, sumber daya manusia, sumber finansial dan sumber informasi), aksi manajemen dalam aktivitas manajemen logistik dan yang terakhir adalah output dari logistik. Unsur-unsur yang berperan dalam komponen tersebut adalah supplier, manajemen perusahaan terutama manajemen logistik dan konsumen berupa output logistik (Hendayani, 2011) .



Gambar 1. Komponen Manajemen Logistik

Proses logistik ini merupakan interpretasi dari fungsi logistik. Proses logistik dari perencanaan dan penetapan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, penghapusan dan pengendalian. Teori lain yang menyebutkan bahwa proses logistik terdiri dari peramalan kebutuhan, pembelian, proses pemesanan, manajemen persediaan, pemeliharaan, transportasi, pengepakan, pergudangan, serta penanganan barang-barang (Hendayani, 2011).

2.3 Logistik Rumah Sakit

Logistik rumah sakit dapat didefinisikan sebagai sejumlah besar dari pembangunan, perencanaan dan pengimplementasian aktivitas yang memfasilitasi aktivitas lainnya seperti pembelian, manajemen persediaan, transportasi, barang dan jasa yang membentuk bagian dari layanan medis yang disediakan untuk pasien. Selain itu, konteks dari logistik sebuah rumah sakit juga mengandung pengertian sebagai suatu perbekalan dari sebuah rumah sakit untuk dapat beroperasi (Imron, M., 2010). Berdasarkan pengertian dari logistik rumah sakit, maka dapat diidentifikasi empat kegiatan utama dari logistik rumah sakit, diantaranya adalah;

- 1. Kegiatan manajemen persediaan seperti pembelian, penerimaan dan pengendalian persediaan dan perbekalan;
- 2. Kegiatan manajemen transportasi seperti pengiriman produk farmasi dan medis;
- 3. Kegiatan produksi seperti repacking sediaan farmasi dan alkes dan rekonstitusi;
- 4. Kegiatan distribusi seperti pengiriman barang ke unit terkait.

2.4 Siklus Manajemen Logistik Rumah Sakit



Gambar 2. Siklus Logistik

2.4.1 Pemilihan

Rumah sakit harus menetapkan formularium obat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Formularium ini didasarkan atas misi rumah sakit, kebutuhan pasien, dan jenis pelayanan yang diberikan. Seleksi obat adalah suatu proses kerjasama yang mempertimbangkan baik kebutuhan dan keselamatan pasien maupun kondisi ekonominya. Apabila terjadi kehabisan obat karena keterlambatan pengiriman, stok nasional kurang, atau sebab lain yang tidak diantisipasi sebelumnya maka tenaga kefarmasian harus menginformasikan kepada profesional pemberi asuhan dan staf klinis pemberi asuhan lainnya tentang kekosongan obat tersebut serta saran substitusinya atau mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak luar.

Formularium Rumah Sakit disusun mengacu kepada Formularium Nasional. Formularium Rumah Sakit merupakan daftar obat yang disepakati staf medis, disusun oleh Komite Farmasi dan Terapi yang disetujui oleh Direktur Rumah Sakit dan ditetapkan oleh Direktur PT. Formularium sekurang-kurangnya dikaji setahun sekali berdasarkan atas informasi tentang keamanan dan efektivitas. Kriteria pemilihan, penambahan, dan penghapusan obat selengkapnya dijelaskan pada Pedoman Kerja Komite Farmasi dan Terapi. Obat baru yang ditambahkan dalam formularium dilakukan pemantauan penggunaan obat bila terjadi reaksi obat yang tidak diharapkan, efek samping, serta *medication error*. Kepatuhan penggunaan obat terhadap formularium rumah sakit baik dari persediaan maupun penggunaannya didokumentasikan pada formulir monitoring dan evaluasi dan dibahas dalam rapat Komite Farmasi dan Terapi.

2.4.2 Seleksi Pemasok

Rumah Sakit harus menjamin semua pasien mendapatkan perbekalan farmasi yang berkualitas sehingga perlu bagi rumah sakit untuk menyeleksi, memeriksa integritas setiap pemasok / supplier dalam rantai distribusi perbekalan farmasi agar dapat memastikan bahwa perbekalan farmasi yang beredar di rumah sakit senantiasa bermutu dan aman bagi pasien. Hendaknya dalam tahap seleksi pemasok / *supplier* Rumah Sakit harus memperhatikan beberapa hal berikut ini :

1. Akte pendirian perusahaan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
2. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP).
3. NPWP.
4. Izin Pedagang Besar Farmasi - Penyalur Alat Kesehatan (PBF - PAK).
5. Perjanjian Kerja Sama antara distributor dan *principal* serta rumah sakit.
6. Nama dan Surat izin Kerja Apoteker untuk apoteker penanggung jawab PBF.
7. Alamat dan denah kantor PBF.
8. Surat garansi jaminan keaslian produk yang didistribusikan (dari *principal*).
9. Pemasok yang menyalurkan narkotika wajib memiliki ijin khusus sebagai fasilitas distribusi atau industri farmasi yang memproduksi narkotika. Izin khusus menyalurkan atau memproduksi narkotika diterbitkan oleh Menteri Kesehatan.

Rumah Sakit harus memastikan bahwa obat diproduksi dengan menerapkan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) dan didistribusikan oleh distributor resmi yang juga menerapkan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik). Hal ini merupakan suatu jaminan bahwa perbekalan farmasi

yang akan diadakan di rumah sakit dari *principal* dan distributor tertentu tersebut bermutu dan aman bagi pasien serta mendatangkan manfaat untuk mendukung keberhasilan terapi pasien.

Untuk memastikan bahwa distributor dapat menjamin mutu perbekalan farmasi yang disuplai ke rumah sakit, Rumah Sakit perlu untuk melakukan peninjauan lapangan terkait prosedur penyimpanan, fasilitas penyimpanan, prosedur pendistribusian, dan fasilitas pendistribusian di lokasi distributor berada. Dalam kunjungan tersebut, diharapkan rumah sakit dapat memilih *supplier* yang benar-benar berkomitmen untuk menjaga mutu perbekalan farmasi.

Pengendalian dan pengkajian seleksi pemasok/ *supplier* ini tertuang dalam sebuah kontrak perjanjian kerjasama yang mana harus mencakup manajemen resiko mutu yang meliputi :

1. Pengadaan harus berasal dari jalur resmi dengan mempertimbangkan pemilihan pemasok dan pemilihan metode pengadaan.
2. Pengadaan harus berdasarkan kontrak termasuk hak akses untuk meninjau ke tempat penyimpanan dan transportasi sewaktu-waktu.
3. Pengadaan harus menjamin garansi keaslian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan dilengkapi :

Barang	Lampiran
Sediaan Farmasi	- Nomor Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Alat Kesehatan	- Nomor Izin Edar dari Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan - <i>Certificate of Origin</i>
Bahan Medis Habis Pakai	- Nomor Izin Edar dari Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
B3 (Bahan Berbahaya danBeracun)	- <i>Material Safety Data Sheet</i> (MSDS) atau Lembar Data Pengaman (LDP)

4. Pengadaan harus memenuhi persyaratan masa kadaluwarsa minimal 2 tahun dari tanggal dilakukan pengadaan.

2.4.3 Perencanaan dan Penetapan Kebutuhan

Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien (Aditama 2012). Dalam perencanaan dan penetapan kebutuhan terdapat hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan proses tersebut, hal-hal tersebut diantaranya adalah jenis dan spesifikasi logistik, metode/cara pengadaan, jumlah logistik, waktu pengadaan, tempat/asal pengadaan dan rencana harga logistik (Hendayani 2011).

Kebutuhan logistik rumah sakit dihitung berdasarkan dari suatu analisa tentang persediaan logistik yang ada, yang masih dapat digunakan, yang masih memerlukan perbaikan atau memang harus diganti dengan yang baru (Imron, M., 2010). Penentuan kebutuhan akan logistik rumah sakit termasuk jumlahnya merupakan salah satu aktivitas yang penting dan sangat menentukan aktivitas selanjutnya. Hal ini dikarenakan penentuan kebutuhan logistik merupakan tahapanawal dalam siklus pengelolaan logistik rumah sakit. Sekali salah menentukan dan menghitung kebutuhan logistik rumah sakit, maka akan salah pula untuk melakukan perencanaan, pengusulan anggaran dan seterusnya.

Dalam perencanaan kebutuhan obat menggunakan metode kombinasi ABC dan VEN sebagai salah satu langkah efisiensi. Untuk itu dilakukan beberapa langkah evaluasi dalam perencanaan kebutuhan dengan RKO (Rencana Kebutuhan Obat).

Teknik evaluasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1) Kombinasi ABC dan VEN

Analisis ABC menunjukkan peringkat/ ranking dimana urutan dimulai dengan yang terbaik/ terbanyak. Analisis ABC mengelompokkan item obat berdasarkan kebutuhan dananya, yaitu:

a. Kelompok A:

Adalah kelompok jenis obat yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 70% dari jumlah dana obat keseluruhan

b. Kelompok B:

Adalah kelompok jenis obat yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 20%.

c. Kelompok C:

Adalah kelompok jenis obat yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 10% dari jumlah dana obat keseluruhan.

Berdasarkan berbagai observasi dalam manajemen persediaan, yang paling banyak ditemukan adalah tingkat konsumsi pertahun hanya diwakili oleh relatif sejumlah kecil item. Sebagai contoh, dari pengamatan terhadap pengadaan obat dijumpai bahwa sebagian besar dana obat (70%) digunakan untuk pengadaan 10% dari jenis atau item obat yang paling banyak digunakan, sedangkan sisanya sekitar 90% jenis atau item obat menggunakan dana sebesar 30%. Dengan analisis ABC, jenis-jenis obat ini dapat diidentifikasi, untuk kemudian dilakukan evaluasi lebih lanjut. Evaluasi ini misal dengan mengoreksi kembali apakah penggunaannya memang banyak atau apakah ada alternatif sediaan lain yang lebih efisien dari segi biaya (misalnya nama dagang lain, bentuk sediaan lain, dsb). Evaluasi terhadap jenis efektif dibandingkan evaluasi terhadap obat yang relatif memerlukan anggaran sedikit

Analisis VEN, untuk evaluasi aspek medik/terapi. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana obat yang terbatas dengan mengelompokkan obat berdasarkan manfaat tiap jenis obat terhadap kesehatan. Semua jenis obat yang tercantum dalam daftar obat dikelompokkan kedalam tiga kelompok berikut :

a. Kelompok V (Vital): Adalah kelompok obat yang mampu menyelamatkan jiwa (life saving). Contoh: obat syok anafilaksis.

b. Kelompok E (Esensial): Adalah kelompok obat yang bekerja pada sumber penyebab penyakit dan paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan. Contoh :

(a) Obat untuk pelayanan kesehatan pokok (contoh: antidiabetes, analgesik, antikonvulsi), (b) Obat untuk mengatasi penyakit penyebab kematian terbesar.

c. Kelompok N (Non Esensial): Merupakan obat penunjang yaitu obat yang kerjanya ringan dan biasa dipergunakan untuk menimbulkan kenyamanan atau untuk mengatasi keluhan ringan. Contoh: suplemen

Penggolongan obat sistem VEN dapat digunakan untuk :

a. Penyesuaian rencana kebutuhan obat dengan alokasi dana yang tersedia. Obat yang perlu ditambah atau dikurangi dapat didasarkan atas pengelompokan obat menurut VEN.

b. Penyusunan rencana kebutuhan obat yang masuk kelompok V

agar selalu tersedia. Untuk menyusun daftar VEN perlu ditentukan lebih dahulu kriteria penentuan VEN yang sebaiknya disusun oleh suatu tim. Kriteria yang disusun dapat mencakup berbagai aspek antara lain aspek klinis, konsumsi, target kondisi dan biaya. Digunakan untuk menetapkan prioritas untuk pengadaan obat dimana anggaran yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 2. Kombinasi ABC dan VEN

	A	B	V
V	VA	VB	VC
E	EA	EB	EC
N	NA	NB	NC

Metode gabungan ini digunakan untuk melakukan pengurangan obat. Mekanismenya adalah :

- a. Obat yang masuk kategori NA menjadi prioritas pertama untuk dikurangi atau dihilangkan dari rencana kebutuhan, bila dana masih kurang, maka obat kategori NB menjadi prioritas selanjutnya dan obat yang masuk kategori NC menjadi prioritas berikutnya. Jika setelah dilakukan dengan pendekatan ini dana yang tersedia masih juga kurang lakukan langkah selanjutnya.
- b. Pendekatannya sama dengan pada saat pengurangan obat pada kriteria NA, NB, NC dimulai dengan pengurangan obat kategori EA, EB dan EC.

2) Revisi rencana kebutuhan obat

Bila langkah-langkah dalam analisis ABC maupun VEN terlalu sulit dilakukan atau diperlukan tindakan cepat untuk mengevaluasi daftar perencanaan, sebagai langkah awal dapat dilakukan suatu evaluasi cepat (rapid evaluation), misalnya dengan melakukan revisi daftar perencanaan obat. Namun sebelumnya, perlu dikembangkan dahulu kriterianya, obat atau nama dagang apa yang dapat dikeluarkan dari daftar. Manfaatnya tidak hanya dari aspek ekonomi dan medik, tetapi juga dapat berdampak positif pada beban penanganan stok

Proses perencanaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain anggaran yang tersedia, penertapan prioritas sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, sisa persediaan, data pemakaian periode lalu, waktu tunggu pemesanan, rencana pengembangan. Sifat dari kebutuhan logistik rumah sakit dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah (Imron, M., 2010):

1. Rutin

Kebutuhan rumah sakit yang bersifat rutin atau mau tidak mau harus dibeli, dan jika tidak dibeli maka operasionalisasi rumah sakit akan terganggu. Kebutuhan rumah sakit yang seperti ini biasanya sudah menjadi perencanaan rutin dan hanya dinaikkan lebih kurang 10% dari kebutuhan nyata. Proses pembelian dilakukan dalam 2 kali periode dalam 2 minggu melalui sistem ROP (*Reorder point*) dan pembelian Farnasi Reguler. Rumus perhitungan ROP adalah sebagai berikut :

$$Q=SK+SP+(WT\times D)-SS$$
 - a. Q = Jumlah obat yang diminta
 - b. SK = Stok Kerja (Pemakaian rata-rata)
 - c. SP = Stok Pengaman (*Safety Stock*)
 - d. WT = Waktu Tunggu (*Lead Time*)
 - e. D = Rata-rata pemakaian per hari
 - f. SS = Sisa Stok (Stok yang masih ada)

2. Mendesak

Istilah mendesak ini akan sangat beragam bagi orang untuk mendefinisikannya. Untuk menentukan sesuatu kebutuhan logistik rumah sakit yang termasuk dalam kategori kebutuhan mendesak, maka harus ada ukuran atau kriteria yang jelas.

3. Periodik

Kebutuhan yang sifatnya periodik biasanya sudah dapat dihitung baik secara kuantitatifnya maupun besarnya anggaran yang harus disiapkan untuk keperluan tersebut. Disebut periodik artinya tetap dalam lingkup tahun anggaran yang berjalan sehingga dalam satu tahun anggaran, kebutuhan yang dimaksud tersebut dapat terpenuhi secara periodik.

2.4.4 Penganggaran

Penganggaran merupakan kegiatan untuk merumuskan rincian penentuan kebutuhan dalam suatu skala standar tertentu, yaitu skala mata uang dan jumlah biaya, dengan memperhatikan pengarahannya dan pembatasan yang berlaku baginya. Jika telah ada penentuan anggaran untuk barang yang akan diadakan, maka pengadaan barang akan lebih terarah, efektif dan efisien. Untuk memenuhi kebutuhan logistiknya, suatu rumah sakit harus menyusun anggaran yang harus dikeluarkan setiap tahunnya yaitu Rancangan Bisnis dan Anggaran (RBA) (Imron, M., 2010).

2.4.5 Pengadaan

Pengadaan merupakan proses pemenuhan kebutuhan barang/jasa dengan kualitas yang terbaik dan harga yang minimal. Pengadaan meliputi langkah- langkah memilih metode pengadaan, memilih pemasok dan dokumen kontrak pengadaan, pemantauan status pesanan, penerimaan dan pemeriksaan barang menurut Subagya, dikutip oleh Dwiwanty (2018:2). Sedangkan menurut Aditama (2012) fungsi dari pengadaan adalah memenuhi kebutuhan operasional yang telah digariskan dalam fungsi perencanaan dan penentuan kepada instansi-instansi pelaksana. Proses pengadaan untuk barang/jasa Pemerintah, saat ini harus mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam peraturan tersebut, pengadaan barang/jasa harus menerapkan prinsip- prinsip seperti efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Semua proses dari pengadaan barang/jasa sudah dijelaskan dalam Perpres No. 54 tahun 2010. Secara garis besar proses pengadaan barang/jasa terdiri dari;

1. Menentukan metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dapat dilakukan dengan beberapa cara sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku seperti penunjukan langsung, pelelangan umum, pemilihan, seleksi dan sayembara;
2. Pelaksanaan pemilihan dan penetapan penyedia barang/jasa;
3. Pembuatan dan penandatanganan kontrak;
4. Pelaksanaan kontrak.

Sementara itu, antara proses pengadaan, penyimpanan dan penyaluran terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, karena berkaitan dengan barang logistik, yang merupakan tujuan utama dari proses logistik ini. Terdapat elemen – elemen transaksi yang harus diperhatikan diantaranya adalah *order cycle time*, *order preparation*, *inventory availability*, *delivery alternatives*, *delivery time*, *delivery reliability*, *delivery of complete order*, *condition of goods* dan *order status information*.

Pengadaan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo terdiri dari :

1. Pembelian

- a. Pembelian di distributor resmi yang memiliki kontrak dengan RS Prima

Husada.

- b. Pengadaan dapat melakukan pembelian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai pada apotek atau rumah sakit lain yang memiliki kontrak dengan RS Prima Husada untuk menjamin keaslian obat.
2. Produksi ulang sediaan farmasi
 - a. Sediaan farmasi dengan kemasan yang lebih kecil/ repacking, contoh: pengemasan salep burnazin, povidon iodine 20 ml, asam asetat 2%.
 - b. Produksi non steril, contoh: pembuatan chlorine.
3. Sumbangan / dropping/hibah

Contoh : obat TBC, obat HIV, vaksin imunisasi dasar, obat BKKBN,

2.4.6 Penerimaan

Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Penerimaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dilakukan oleh apoteker koordinator penerimaan, distribusi, dan produksi yang dibantu tenaga vokasi farmasi yang kompeten. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang diterima harus diperiksa dan disesuaikan dengan spesifikasi pada order pembelian rumah sakit dan harus sesuai dengan spesifikasi kontrak yang telah ditetapkan. Petugas yang dilibatkan dalam penerimaan harus terlatih baik dalam tanggung jawab dan tugas, serta harus mengerti sifat penting dari sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Semua sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus ditempatkan dalam tempat persediaan, segera setelah diterima, harus segera disimpan dalam tempat penyimpanan sesuai standar.

Alur dalam penerimaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai:

1. Mencocokkan faktur dari distributor dengan surat pesanan.
2. Memeriksa kesesuaian dengan spesifikasi kontrak yang telah ditetapkan.
3. Pengiriman produk dilengkapi dengan persyaratan pengadaan.
4. Jika setelah dilakukan pemeriksaan terdapat item sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis yang tidak sesuai dengan surat pesanan atau kondisi kemasan tidak baik, maka harus segera dikembalikan dengan disertai bukti retur dan surat pesanan asli, dan segera meminta bukti terima pengembalian dari *supplier*. Jika terdapat ketidaksesuaian nomer batch, tanggal kedaluwarsa, dan jumlah antara fisik barang dengan dokumen pengiriman harus dibuat dokumentasi untuk mengklarifikasi ketidaksesuaian tersebut kepada pihak *supplier*
5. Pada saat penerimaan, produk yang harus disimpan dalam suhu dingin yaitu 2° - 8° C atau produk rantai dingin (*cold chain product*) seperti vaksin, petugas penerimaan barang harus melakukan pemeriksaan kondisi fisik produk tersebut dan mengecek dengan alat pemantauan suhu yang disertakan oleh bagian pengiriman barang. Petugas penerimaan barang harus memastikan bahwa suhu saat barang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk produk vaksin yang telah dilengkapi dengan Vaccine Vial Monitor (VVM), petugas penerimaan barang dapat mengecek pada kemasan vaksin untuk memastikan bahwa vaksin diterima dalam keadaan baik dan layak pakai. Setelah memastikan kondisi barang yang diterima, dengan dokumen pengiriman barang/ faktur barang, petugas menandatangani dokumen pengiriman barang dan memberikan stempel rumah sakit. Petugas penerimaan barang harus segera menyimpan produk rantai dingin (*cold chain product*) dalam kulkas vaksin agar tetap terjaga stabilitas sediaannya.

2.4.7 Penyimpanan

Penyimpanan merupakan kegiatan penataan barang agar pada saat diperlukan dapat dilayani dengan cepat dan tepat. Penyimpanan dilakukan agar persediaan dalam

keadaan stabil, terjaga kualitasnya, mudah dicari, mudah diawasi dan terjaga keamanannya. Penyimpanan barang logistik dapat dilakukan dengan metode FEFO (*First Expired First Out*), FIFO (*First In First Out*), *Fast and slow moving*, alfabetis dan kelompok barang. Dalam melakukan penyimpanan ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu penyediaan tempat dan penentuan. Penyimpanan logistik umumnya dilakukan di sebuah gudang. Saat ini, fungsi gudang telah berkembang, tidak hanya sebagai tempat penyimpanan. Banyak organisasi yang memanfaatkan gudang sebagai tempat melakukan berbagai kegiatan yang terkait proses penerimaan, *put away, storing, picking and delivering* (Asosiasi Logistik Indonesia, 2011).

Penyimpanan sediaan farmasi, ala kesehatan, dan bahan medis habis pakai pada Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dapat dikategorikan antara lain berdasarkan jenis sediaan, suhu penyimpanan, bentuk sediaan, dan disusun secara alfabetis untuk mempermudah pencarian. Prinsip yang digunakan dalam penyimpanan adalah secara FEFO dan FIFO untuk menjamin tidak adanya obat *expired*.

Penyimpanan barang di gudang dilakukan dengan menggunakan lemari, rak dan palet. Penyimpanan logistik dengan alat penyimpanan yang sesuai dan dilakukan secara benar maka akan mempermudah petugas gudang dalam melakukan kegiatan lainnya seperti pendistribusian dan pemeliharaan barang, serta menghindari hal-hal yang dapat merusak barang. Untuk produk-produk yang memiliki pergerakan tinggi dan memiliki bobot yang lebih berat harus diletakkan di dekat pintu gudang dan pada posisi bawah jika diletakkan dalam rak. Untuk obat-obatan tertentu yang membutuhkan penyimpanan khusus, biasanya disimpan dalam sebuah kulkas atau lemari pendingin (Asosiasi Logistik Indonesia, 2011).

Penyimpanan perbekalan farmasi di gudang atau bagian logistik farmasi dapat menggunakan beberapa sistem penataan obat yang dapat digunakan antara lain adalah :

1. *First Expired First Out* (FEFO) : Sistem penataan obat atau perbekalan farmasi dengan meletakkan obat yang mempunyai tanggal kadaluarsa lebih dahulu di depan obat yang mempunyai tanggal kadaluarsa lebih akhir.
2. *First In First Out* (FIFO) : Sistem penataan obat atau perbekalan farmasi dengan meletakkan barang baru (datang terakhir) di belakang barang yang datang sebelumnya;

2.4.8 Pendistribusian

Penyaluran atau distribusi merupakan kegiatan atau usaha untuk mengelola pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lainnya (Putri, Rosmayani & Rosmita, 2018). Faktor yang mempengaruhi penyaluran barang antara lain :

1. Proses administrasi;
2. Proses penyampaian berita (data informasi);
3. Proses pengeluaran fisik barang;
4. Proses angkutan termasuk rantai dingin;
5. Proses pembongkaran dan pemuatan;
6. Pelaksanaan rencana-rencana yang telah ditentukan.

Adapun sistem pendistribusian barang logistik dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Sentralisasi

Sistem sentralisasi merupakan sistem pendistribusian langsung dari gudang penyimpanan ke tempat *user*. Sistem ini biasanya dipakai oleh instansi yang memiliki organisasi kecil, barang logistik tidak banyak dan lokasi gudang tidak jauh dengan tempat pemakaian.

2. Desentralisasi

Sistem desentralisasi merupakan sistem pendistribusian yang dilakukan tidak secara langsung. Sistem ini biasanya dipakai oleh instansi dengan skala besar, jumlah barang banyak, lokasi gudang jauh, jumlah user banyak dan jenis barang

logistik bervariasi.

Berdasarkan mekanisme distribusi perbekalan farmasi di rumah sakit, sistem distribusi terbagi menjadi beberapa tipe yaitu :

1. *Individual Prescribing*

Sistem distribusi ini adalah distribusi obat kepada pasien berdasarkan resep obat dokter untuk tiap pasien. Dalam sistem ini semua obat yang diperlukan untuk pengobatan dilakukan *dispensing* dari instalasi farmasi.

2. *Floor Stock*

Sistem distribusi ini adalah menyiapkan obat yang dibutuhkan pasien di ruangan perawatan kecuali obat mahal atau obat yang jarang digunakan.

3. Kombinasi antara *Individual Prescribing* dengan *Floor Stock*

Sistem distribusi ini adalah distribusi obat dengan menggunakan sistem penulisan resep secara individu dan juga memanfaatkan *floor stock* secara terbatas.

4. *Unit Dose Dispensing* (UDD)

Sistem distribusi ini adalah penyiapan obat dosis tunggal untuk pemakaian selama 24 jam oleh petugas gudang farmasi.

5. *Once Daily Dose* (ODD)

sistem distribusi obat kepada pasien rawat inap yang disiapkan dalam satuan unit dosis siap pakai selama 24 jam.

2.4.9 Pemanfaatan

Pemanfaatan barang dengan sebaik mungkin akan mempermudah kegiatan perusahaan atau rumah sakit. Pemanfaatan untuk setiap golongan barang sifatnya berbeda-beda, antara barang habis pakai (BHP), inventaris dan juga persediaan. Menurut Imron, M. (2010), untuk barang habis pakai memang sangat *urgent* diperlukan dan jumlahnya selalu saja bertambah dari waktu ke waktu tergantung dari aktifitas pelayanan, untuk barang inventaris sifatnya tidak akan habis jika dimanfaatkan namun perlu pemeliharaan, sedangkan untuk barang persediaan sebenarnya termasuk barang habis pakai namun pemanfaatannya secara bertahap, dilakukan periodik atau bahkan digunakan apabila diperlukan.

2.4.10 Pemeliharaan

Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan logistik dan peralatan agar kondisi tetap terjamin dan siap pakai untuk dipergunakan secara efektif dan efisien dan akuntabel, melalui prinsip-prinsip seperti 5R (Ringkas, Rapih, Resik (bersih), Rawat, Rajin) secara terus menerus, *First Expired Date First Out* (FEFO), *First In First Out* (FIFO) serta logistik dan peralatan disusun di atas pallet secara rapih dan teratur, sesuai dengan ketentuan. Aktivitas pemeliharaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu;

1. Perawatan Tidak Terencana (*Unplanned Maintenance*)

Merupakan perawatan yang tidak direncanakan terlebih dahulu, disebabkan peralatan dan fasilitas produksi tidak memiliki rencana serta jadwal perawatan. Kegiatan perawatan ini disebut juga perawatan darurat (*breakdown maintenance* atau *emergency maintenance*) yang didefinisikan sebagai perawatan yang perlu dilaksanakan tindakan untuk mencegah akibat yang fatal seperti kerusakan besar pada peralatan, hilangnya produksi dan keselamatan kerja.

2. Perawatan Terencana (*Planned Maintenance*)

Merupakan kegiatan perawatan yang mengacu pada rencana yang telah disusun dan dilaksanakan serta didokumentasikan. Perawatan ini terbagi dua, yaitu :

a. Perawatan Pencegahan (*Preventive*)

Kegiatan pemeliharaan dan perawatan untuk mencegah timbulnya kerusakan – kerusakan tidak terduga dan menemukan kondisi atau keadaan yang menyebabkan fasilitas produksi mengalami kerusakan pada waktu proses produksi dan mencegah menurunnya fungsi peralatan dan fasilitas. Perawatan

ini dibagi dua, yaitu :

1) Perawatan Rutin

Perawatan rutin adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara rutin setiap hari yaitu dengan pembersihan peralatan.

2) Perawatan Periodik

Perawatan periodik adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara periodik atau jangka waktu tertentu seperti memeriksa komponen-komponen peralatan.

b. Perawatan Perbaikan (*Corrective Maintenance*)

Kegiatan perawatan yang sudah direncanakan berupa penggantian komponen yang sudah tidak berfungsi. Perawatan perbaikan dapat berupa perbaikan yang tidak ditemukan pada saat pemeriksaan seperti penggantian komponen secara serentak juga *overhaul* (perbaikan menyeluruh) terencana.

2.4.11 Penghapusan

Penghapusan adalah kegiatan untuk menghilangkan dari daftar inventaris bahan atau barang oleh karena barang sudah rusak, kadaluarsa sehingga sudah tidak layak untuk dipergunakan lagi, hilang, susut atau sesuai peraturan harus dihilangkan (Asosiasi Logistik Indonesia, 2011). Secara lebih operasional, penghapusan logistik merupakan pengakhiran fungsi logistik dengan pertimbangan-pertimbangan dan argumentasi-argumentasi tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kriteria sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dapat dihapus dari logistik antara lain sediaan yang *slow moving*, sediaan yang dalam proses recall oleh Pemerintah/BPOM, serta sediaan yang *death stock* dalam waktu 3 bulan. Untuk melakukan penghapusan logistik sendiri, terdiri dari beberapa cara yang dapat dilakukan, diantaranya adalah :

1. Dijual atau dilelang

Dengan cara ini berarti organisasi akan memperoleh sejumlah kontraprestasi berupa uang hasil penjualan logistik.

2. Ditukar dengan logistik lain yang dibutuhkan oleh institusi

Dengan cara ini organisasi akan menukarkan logistik yang dimiliki dengan logistik yang dibutuhkan oleh organisasi. Dengan cara ini harus mempertimbangkan dan mengacu pada prinsip-prinsip pengadaan logistik dengan cara menukarkan, antara lain logistik yang ditukarkan harus benar-benar sudah tidak dibutuhkan institusi, nilai logistik yang dipertukarkan harus sepadan dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

3. Dipindahkan

Penghapusan dengan cara dipindahkan adalah secara fisik logistik yang sudah tidak dibutuhkan dimutasikan ke unit kerja lain ataupun kantor/ institusi cabang. Dengan demikian, pemusnahan logistik ini sifatnya masih dalam ruang lingkup organisasi internal

4. Dihilangkan

Penghapusan logistik dengan cara dihibahkan berarti organisasi memberikan secara cuma-cuma kepada pihak/organisasi lain yang membutuhkan logistik yang dihapuskan.

5. Pemanfaatan kembali

Penghapusan dengan cara pemanfaatan kembali berarti barang yang dihapus kemudian diubah menjadi barang lain yang memiliki fungsi dan kegunaan berbeda dari fungsi dan kegunaan barang semula.

6. Dimusnahkan

Penghapusan logistik dengan cara dimusnahkan adalah logistik benar-benar dihilangkan dan hal ini dilakukan apabila cara penghapusan logistik yang lain sudah tidak mungkin untuk diimplementasikan.

2.4.12 Pengendalian

Pengendalian merupakan fungsi inti dari pengelolaan logistik yang meliputi usaha untuk memonitor dan mengamankan keseluruhan pengelolaan logistik (Aditama, 2012). Bentuk dari pengendalian bermacam-macam, dari yang paling sederhana hingga yang kompleks. Contoh pengendalian yang sederhana yang biasa dilakukan adalah pencatatan. Di rumah sakit sendiri, pencatatan memiliki fungsi untuk pengendalian terhadap berjalannya siklus logistik di rumah sakit (Imron, M., 2010). Di dalam suatu pengendalian terdapat beberapa kegiatan seperti pengumpulan, pemrosesan, penerimaan, pelaporan dan penyimpanan data yang digunakan sebagai informasi untuk kegiatan pengendalian proses logistik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengendalian terhadap persediaan obat- obatan adalah jumlah stok, perkiraan jumlah stok, pengendalian stok dan pengendalian masa guna obat.

2.4.13 Jenis Perbekalan Farmasi yang Paling Berisiko

a. Daftar Obat-obatan dan Reagen yang membutuhkan *Cold Chain*

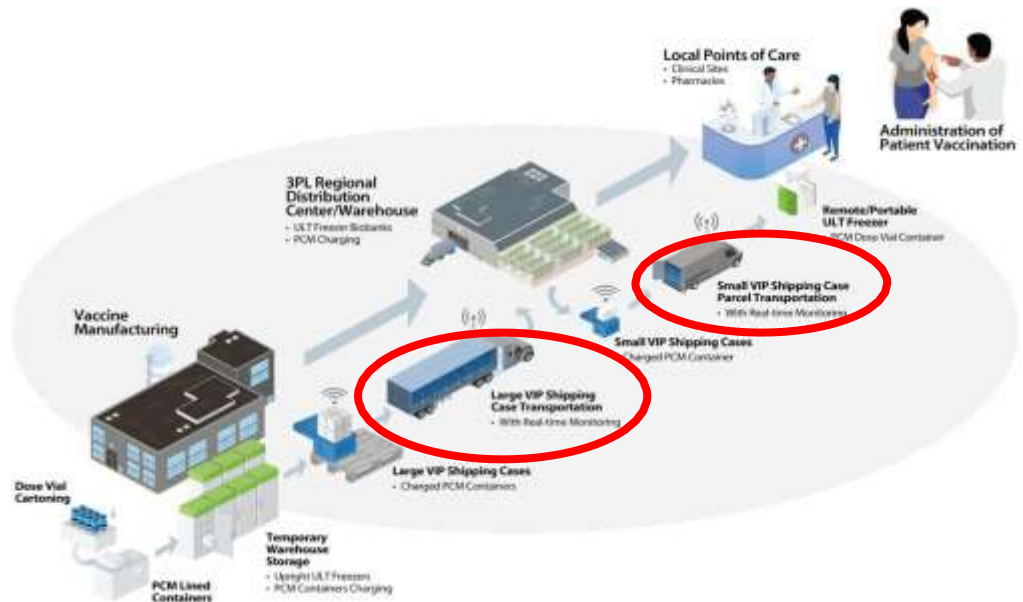
No	Nama Sediaan	Jenis Sediaan
Golongan Obat-obatan High Alert (membutuhkan <i>Cold Chain</i>)		
1	Apidra Insulin 100 lu/MI	Insulin
2	Benzolac CI Cr 10 Gr	Obat luar
3	Biosat-15 (Ats 1500 lu)	Produk Biologi
4	Biosave Inj 5 MI	Produk Biologi
5	Carbazochrome Inj 50 Mg/10ml	Injeksi
6	Ezelin Insulin 100 lu / MI	Insulin
7	Ez Rapid Insulin 100 lu / MI	Insulin
8	Fibrion Inj 1500000 lu	Fibrinolitik
9	Hemapo 3000 lu Inj	Produk darah
10	Human Albumin 20%	Albumin
11	Lantus Xr 300iu/MI	Insulin
12	Methyletergometrine Inj 02 Mg/MI	Injeksi
13	Novorapid Insulin	Insulin
14	Notrixum Inj 1% 2.5 MI	Injeksi
15	Osflex Inj 25 Mg/25 MI	Injeksi
16	Oxytocin Inj 10 lu/1 MI	Injeksi
17	Perossal 2x6	Injeksi
18	Renogen 3000 lu	Produk darah
19	Ryzodeg Flextouch	Insulin
20	Sansulin Log-G Dispopen	Insulin
21	Sansulin Rapid Dispopen	Insulin
22	Tetagam P Inj 1 MI (250 lu)	Produk Biologi
23	Tramus Inj 1% 25 MI	Injeksi
24	Vagistin Ovula	Obat luar
25	Zyfort Inj 3 MI	Injeksi
Perbekalan Medis berisiko tinggi (membutuhkan <i>Cold Chain</i>):		
1	CREATININ	Reagen Laboratorium
2	CHOLESTROL	Reagen Laboratorium
3	BIL. DIRECT	Reagen Laboratorium
4	URIC ACID	Reagen Laboratorium
5	HDL	Reagen Laboratorium
6	LDL	Reagen Laboratorium

7	UREA	Reagen Laboratorium
8	BIL. TOTAL	Reagen Laboratorium
9	TRIGLYSERID	Reagen Laboratorium
10	ALBUMIN	Reagen Laboratorium
11	GLUKOSA	Reagen Laboratorium
12	AST	Reagen Laboratorium
13	ALT	Reagen Laboratorium
14	LIPOTROL	Reagen Laboratorium
15	E CALL	Reagen Laboratorium
16	S CALL	Reagen Laboratorium
17	NOTROL	Reagen Laboratorium
18	THROMBOPLASTIN	Reagen Laboratorium
19	HEPARIN	Reagen Laboratorium
20	HBA1C	Reagen Laboratorium
21	TSH	Reagen Laboratorium
22	FT4	Reagen Laboratorium
23	TROPONIN	Reagen Laboratorium
24	WIDAL O	Reagen Laboratorium
25	WIDAL H	Reagen Laboratorium
26	WIDAL A	Reagen Laboratorium
27	WIDAL B	Reagen Laboratorium
28	GOLDA A	Reagen Laboratorium
29	GOLDA B	Reagen Laboratorium
30	GOLDA RH	Reagen Laboratorium
31	GEM 3500	Reagen Laboratorium
32	URIT DILLUENT	Reagen Laboratorium
33	URIT DETERJEN	Reagen Laboratorium
34	CVP	Reagen Laboratorium
35	URIT SHEAT	Reagen Laboratorium
36	TOTAL PROTEIN	Reagen Laboratorium
37	HBSAG VIDAS	Reagen Laboratorium
38	SALMONELLA TUBEX	Reagen Laboratorium
39	QC URIT	Reagen Laboratorium
40	TUBERCULLIN	Reagen Laboratorium
41	APTT (BE)	Reagen Laboratorium
42	CaCL (BE)	Reagen Laboratorium
43	HDL LDL CAL	Reagen Laboratorium
44	RF	Reagen Laboratorium
45	WASHFLUID	Reagen Laboratorium
46	WASHING SOLUTION	Reagen Laboratorium
47	QC FH	Reagen Laboratorium
48	URIT LYSE	Reagen Laboratorium
49	URIT PROBE CLEANSER	Reagen Laboratorium

b. Peralatan Medis Berisiko Tinggi

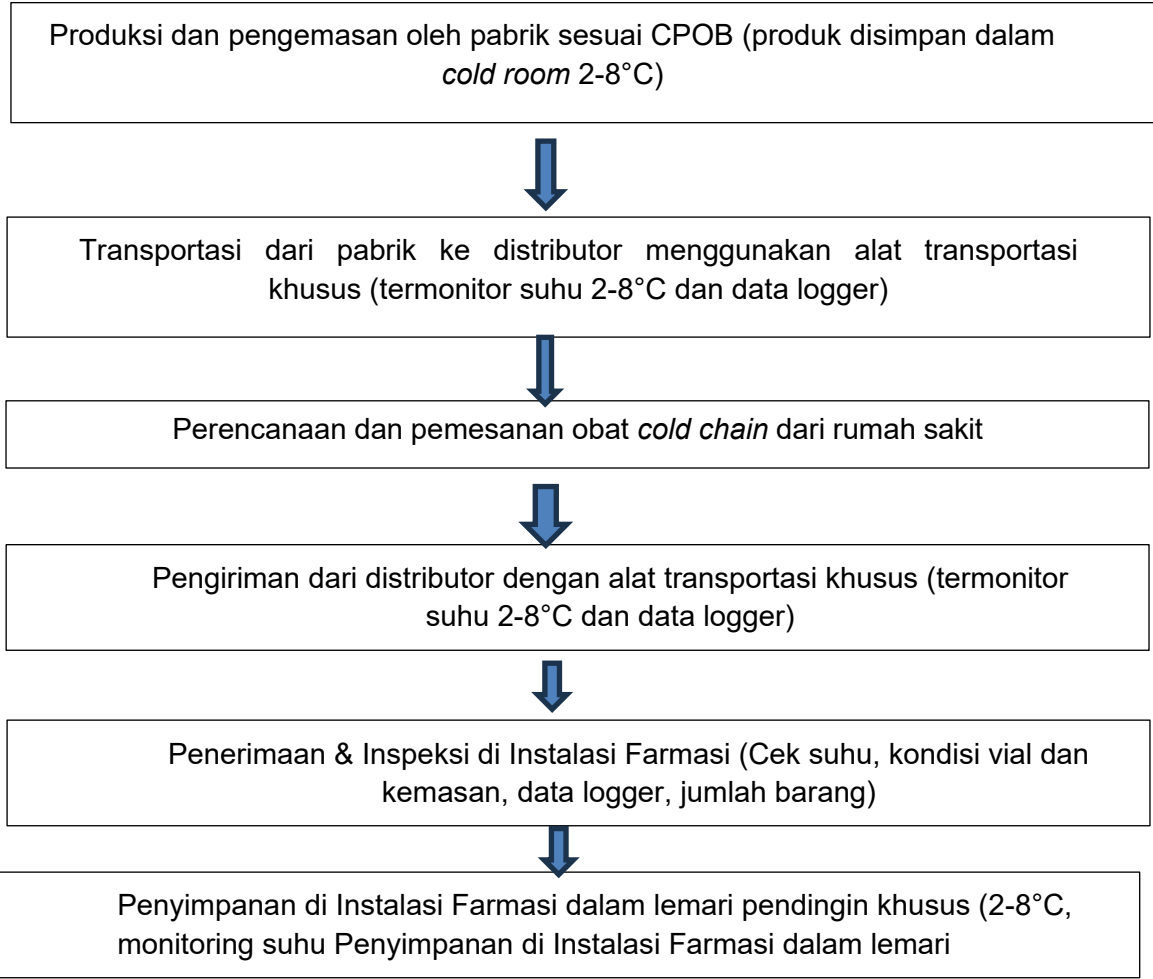
Alat penyimpanan *cold chain* yaitu *vaccine refrigerator* dan lemari pendingin khusus (*showcase*).

2.4.14 Alur Cold Chain Product



Berikut adalah bagan alur pengadaan obat *cold chain* mulai dari proses produksi hingga sampai ke tangan pasien. Bagian bertanda merah merupakan titik-titik berisiko untuk mempertahankan kualitas sediaan yang akan diberikan kepada pasien. Pada titik ini terdapat beberapa faktor seperti jarak yang membutuhkan waktu cukup panjang dimana kondisi penyimpanan harus tetap terkontrol untuk menjaga mutu obat. Jarak dan waktu yang semakin jauh dapat mempengaruhi kualitas dan keamanan sediaan sehingga perlu monitoring dan diusahakan sedemikian rupa agar tetap terjaga sampai tujuan.

Bagan Alur Cold Chain :



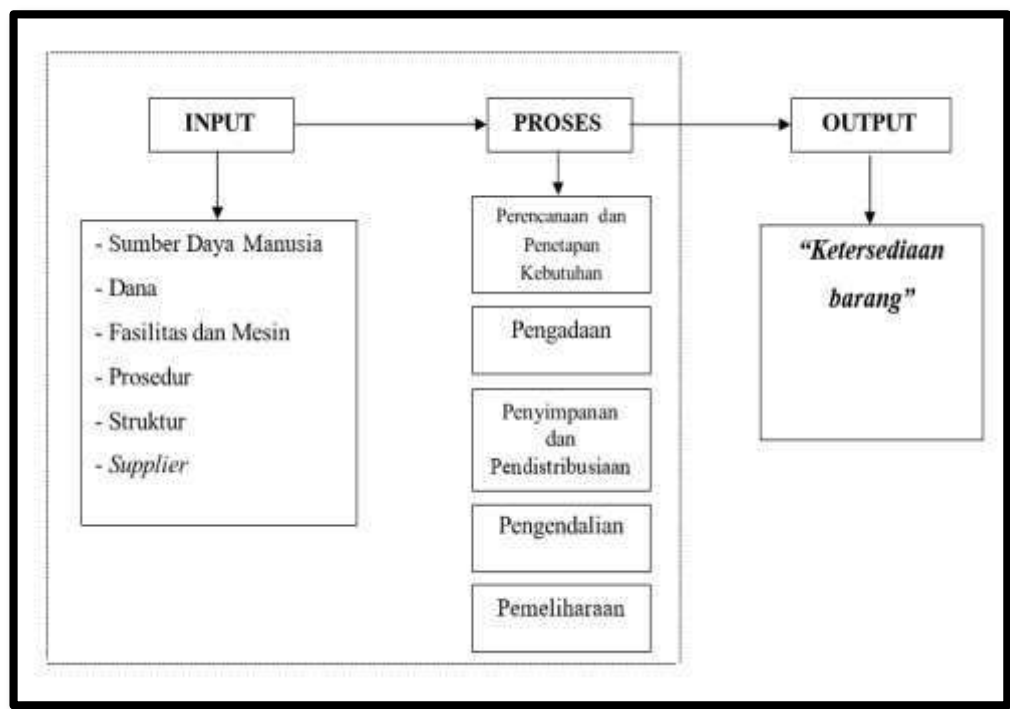
2.4.15 Cold Chain Product Management

Daftar Risiko dan Upaya Penanganan Risiko

Titik Risiko	Risiko	Pelacakan dan Upaya Penanganan Risiko
Produsen	a. Pemilihan Bahan Baku : Tidak sesuai standar. b. Proses Produksi : Terkontaminasi, Substandar dan/ atau tidak sesuai standar. c. Palsu / Illegal d. Termolabil : Suhu Penyimpanan sebelum didistribusikan tidak terkontrol.	☐ Data / Informasi dari BPOM ☐ Dokumen CPOB, COA ☐ Pengujian BA-BE ☐ Dokumen Perijinan dan Company Profile
Transportasi (Dari Produsen Ke Distributor)	a. Jarak Pabrik dan Distributor Pusat maupun Cabang jauh : membutuhkan waktu lebih lama. b. Kondisi Penyimpanan dalam Sarana Transportasi : sediaan terkontaminasi / rusak. c. Termolabil : suhu penyimpanan dalam sarana transportasi tidak mendukung. d. Kemasan Vaksin : tidak melindungi sediaan dari cahaya atau guncangan selama perjalanan.	☐ Cek Kemasan saat diterima dari Pabrik ☐ Data/ Informasi pemantauan suhu dan kondisi penyimpanan dalam sarana transportasi tersedia thermometer dan disimpan dalam coolbox.
Distributor	a. Jarak Pabrik dan Distributor Pusat maupun Cabang jauh : membutuhkan waktu lebih lama. b. Kondisi Penyimpanan dalam Sarana Transportasi : sediaan terkontaminasi / rusak. c. Termolabil : suhu penyimpanan dalam sarana transportasi tidak mendukung. d. Kemasan Vaksin : tidak melindungi sediaan dari cahaya atau guncangan selama perjalanan. e. Kondisi penyimpanan di distributor tidak terkontrol : sediaan terkontaminasi / rusak.	☐ Cek Kemasan saat diterima dari Pengiriman/ Ekspedisi. ☐ Data/ Informasi pemantauan suhu dan kondisi penyimpanan dalam sarana transportasi tersedia thermometer dan disimpan dalam coolbox. ☐ Surat Penunjukan Distributor oleh Produsen. ☐ Sertifikat CDOB dan dokumen perijinan Distributor ☐ Visitasi ke Gudang Distributor ☐ Data pemantauan suhu dan kondisi penyimpanan di Gudang Distributor. ☐ Data/ Informasi dari BPOM

Transportasi (Dari Distributor Ke Konsumen)	a. Jarak Distributor dan Konsumen jauh : membutuhkan waktu lebih lama. b. Kondisi Penyimpanan dalam Sarana Transportasi : sediaan terkontaminasi / rusak. c. Termolabil : suhu penyimpanan dalam sarana transportasi tidak mendukung. d. Kemasan Vaksin : tidak melindungi sediaan dari cahaya atau guncangan selama perjalanan.	❑ Cek Kemasan saat diterima dari Distributor ❑ Data/ Informasi pemantauan suhu dan kondisi penyimpanan dalam sarana transportasi tersedia thermometer dan disimpan dalam <i>coolbox</i>.
Penerimaan dan Inspeksi dari Distributor	a. Suhu obat naik, obat rusak/tidak efektif	❑ Petugas inspeksi wajib memeriksa suhu saat kedatangan dengan data logger, menolak obat jika suhu di luar batas toleransi.
Gudang Farmasi Rumah Sakit	a. Kondisi Penyimpanan di Gudang Farmasi Rumah Sakit tidak terkontrol : sediaan terkontaminasi / rusak b. Kegagalan sistem pendingin, suhu di luar batas c. Perencanaan Kebutuhan kurang baik : penumpukan stok dan atau kadaluarsa sebelum digunakan.	❑ Monitoring Kondisi Penyimpanan di Gudang Farmasi. ❑ <i>Maintenance</i> Kulkas Vaksin dan AC Gudang Farmasi. ❑ Menggunakan lemari pendingin khusus dengan monitoring suhu otomatis 24 jam, alarm jika suhu keluar batas aman. Memiliki genset cadangan jika listrik padam. ❑ Pengiriman Vaksin dari Gudang ke Poliklinik dengan menggunakan <i>coolbox</i> yang disertai thermometer.
Distribusi ke Unit Pelayanan	a. Paparan suhu tinggi saat perjalanan	❑ Distribusi hanya dengan menggunakan cold box bersuhu stabil (dilengkapi thermometer digital). Petugas wajib cek suhu sebelum dan setelah distribusi.
Penyimpanan di Unit Pelayanan	b. Lemari pendingin rusak, pemadaman listrik	❑ Menyediakan lemari pendingin khusus di setiap unit pelayanan, monitoring rutin, pencatatan suhu 2x sehari, tersedia cold box cadangan.

BAB III
FAKTOR YANG TERKAIT LOGISTIK



Gambar 3. Kerangka Konsep Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Kebutuhan Logistik Farmasi di Gudang Farmasi Rumah Sakit Prima Husada

3.1 Faktor Input

3.1.1 Sumber Daya Manusia

Berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu organisasi. Dalam praktiknya, manusia yang membuat tujuan dan melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. SDM yang terdapat di gudang farmasi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo berdasarkan data tahun 2025 berjumlah 3 (Tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Apoteker dan 2 (dua) orang Tenaga Vokasi Farmasi. Cara kerja di antara mereka adalah selalu *stand by* di gudang farmasi selama jam kerja berlangsung. Masing – masing staf gudang farmasi sudah memiliki tugas dan tanggung jawab yang terbagi berdasarkan kelompok barang. Ada yang bertanggung jawab terhadap barang umum, teknik dan juga farmasi.

3.1.2 Dana

Merupakan unsur manajemen yang berpengaruh terhadap hasil kegiatan. Dapat diukur dari jumlah dan efisiensi penggunaannya. Uang juga dapat menjadi alat dalam proses pencapaian tujuan, jika digunakan secara rasional. Untuk memenuhi semua kebutuhan logistik rumah sakit, baik medis maupun non medis dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang digunakan berasal dari pendapatan rumah sakit saja, karena RS Prima Husada Sukorejo merupakan rumah sakit swasta kepemilikan perorangan.

3.1.3 Fasilitas dan Mesin

Unsur yang dibutuhkan untuk membantu melakukan pekerjaan dan proses untuk mencapai tujuan. Penggunaan mesin dapat meningkatkan hasil dan keuntungan, serta membuat proses menjadi lebih efektif dan efisien. Untuk menunjang para pegawai di gudang farmasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, ketersediaan akan fasilitas dan mesin merupakan salah satu hal yang penting dan perlu diperhatikan. Ketersediaan, kelengkapan dan kondisi yang layak pakai dari fasilitas dan mesin yang digunakan untuk menunjang kerja para pegawai yang terdapat di gudang farmasi pada dasarnya sudah sesuai kebutuhan.

Sementara itu, untuk mesin yang terdapat di gudang farmasi yaitu berupa satu set komputer beserta mesin cetak (printer) dan sudah tersambung dengan internet sebanyak 2 (dua) unit. Kedua unit komputer ini digunakan untuk SDM yang terdapat di gudang farmasi. Selain fasilitas dan mesin yang digunakan untuk menunjang pekerjaan para pegawai, terdapat juga fasilitas yang berhubungan dengan fungsi gudang farmasi sebagai pusat penyimpanan. Hal ini terkait dengan masalah tempat dan alat penyimpanan yang terdapat di gudang farmasi. Untuk alat penyimpanan yang digunakan di gudang farmasi, yaitu berupa rak – rak penyimpanan dan kulkas yang digunakan untuk menyimpan obat-obatan jenis tertentu. Selain itu, juga disediakan *trolley* untuk mengantar atau mendistribusikan barang dari gudang farmasi ke depo farmasi maupun ke unit – unit yang membutuhkan.

Sementara itu, berdasarkan hasil observasi, fasilitas dan mesin yang tersedia di gudang farmasi guna menunjang pekerjaan para pegawainya memang sudah dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dengan tersediannya fasilitas kerja seperti meja, kursi, ATK, dan sebagainya. Untuk fasilitas penyimpan, luas dari gudang farmasi yang merupakan sebagai tempat penyimpanan untuk semua barang farmasi memang masih kurang luas dan terlihat penumpukan kardus – kardus barang farmasi tersebut. Alat penyimpanan yang dipakai seperti rak – rak dan lemari sudah tersedia. Untuk penyimpanan reagen, vaksin dan obat-obat tertentu ditempatkan di kulkas pendingin. Terdapat 1 (satu) kulkas/*showcase* dan 2 (dua) *vaccine refrigerator* yang tersedia di gudang farmasi dan semuanya dalam keadaan baik.

3.1.4 Prosedur

Dalam menjalankan suatu proses kerja diperlukan standar atau prosedur yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan segala pekerjaan yang ada. Prosedur yang disebut juga dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku, diantaranya adalah :

1. SPO Pengadaan Sediaan Farmasi, Vaksin, Reagen, Alkes, BMHP dan B3;
2. SPO Penerimaan Barang dari Distributor;
3. SPO Penyimpanan Sediaan Farmasi Vaksin, Reagen, Alkes, BMHP dan B3;
4. SPO Permintaan Barang dari Unit ke Gudang Farmasi;
5. SPO Pendistribusian Barang dari Gudang Farmasi;
6. SPO Retur Sediaan Farmasi, Vaksin, Reagen, Alkes, BMHP dan B3;
7. SPO Penarikan Sediaan Farmasi, Vaksin, Reagen, Alkes, BMHP dan B3;
8. SPO Pemusnahan Sediaan Farmasi Vaksin, Reagen, Alkes, BMHP dan B3 yang Telah Kadaluarsa/Rusak.

SPO digunakan oleh para pegawai gudang farmasi dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya. SPO yang digunakan dibuat oleh Apoteker Gudang Farmasi dan ditetapkan serta ditandatangani oleh direktur rumah sakit. Perbaikan SPO yang biasanya dilakukan adalah penggantian kata – kata agar menjadi lebih mudah dipahami dan pembenaran penulisan, jika sudah direvisi maka kembali diajukan ke direktur.

3.1.5 Keberadaan dalam Struktur Organisasi

Dilihat dalam struktur rumah sakit secara keseluruhan, memang tidak akan ditemukan kata – kata “logistik” di antara semua bagian struktural yang ada. Hal ini dikarenakan di Rumah Sakit Prima Husada tidak menjadikan “logistik” sebagai suatu bagian dari unit struktural. Selain itu, saat ini gudang farmasi juga bukan sebagai sebuah instalasi di rumah sakit, karena terletak di bawah Instalasi farmasi, namun memiliki Apoteker Gudang Farmasi. Dengan adanya hal tersebut diharapkan adanya perubahan yang lebih baik, khususnya terkait dengan proses pengelolaan logistik rumah sakit yang terdapat di gudang farmasi seperti lebih mempermudah pengawasan proses pengelolaan, lebih mempercepat proses dari setiap tahapan kegiatan logistik rumah sakit dan sebagainya.

3.1.6 Supplier

Supplier atau yang lebih sering disebut rekanan ini merupakan pihak yang berasal dari luar rumah sakit yang mempunyai peran dalam pengadaan logistik rumah sakit. *Supplier* yang terdapat di Rumah Sakit Prima Husada terdiri dari supplier barang umum, farmasi dan teknik, supplier jasa serta kontraktor. *Supplier* yang terpilih merupakan pemenang *tender* yang menawarkan dengan harga yang paling murah dan dengan kualitas yang memenuhi standar serta yang memiliki *trackrecord* yang baik. Evaluasi dari kinerja supplier selama setahun yang menyatakan bahwa hampir semua supplier mendapatkan penilaian baik. Sementara itu, untuk koordinasi antara supplier dengan pihak rumah sakit pada dasarnya juga sudah berjalan baik. Jumlah supplier yang masih bekerja sama untuk menyuplai segala kebutuhan logistik rumah sakit kurang lebih sebanyak 100 *supplier*.

3.2 Faktor Proses

3.2.1 Pelaksanaan Perencanaan dan Penetapan Logistik

Proses perencanaan dan penetapan kebutuhan yang ada di Rumah Sakit Prima Husada mengacu kepada prosedur yang berlaku. Untuk perencanaan kebutuhan logistik dilakukan berdasarkan kelompok barang dan ditujukan sesuai kepada koordinator pengadaan. Mulanya, perencanaan kebutuhan dilakukan oleh masing – masing unit, yang biasanya mengacu pada pemakaian tahun sebelumnya dan sudah ditambah dengan *safety stock (Buffer Stock)* sebesar 10-20%. Seluruh unit kerja membuat RAB (Rencana Anggaran Bisnis). Saat merencanakan dan menentukan kebutuhan barang yang akan diadakan, dilakukan juga penentuan harga untuk setiap jenis barangnya. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah jenis dana yang disediakan dan yang akan digunakan. Selain itu, ketepatan waktu dalam proses ini juga mempengaruhi berlangsungnya proses selanjutnya. Hal ini dikarenakan perencanaan dan penetapan kebutuhan merupakan proses pertama dalam proses pengelolaan logistik rumah sakit sehingga menentukan lancar atau tidaknya untuk proses selanjutnya hingga akhirnya menghasilkan *output*.

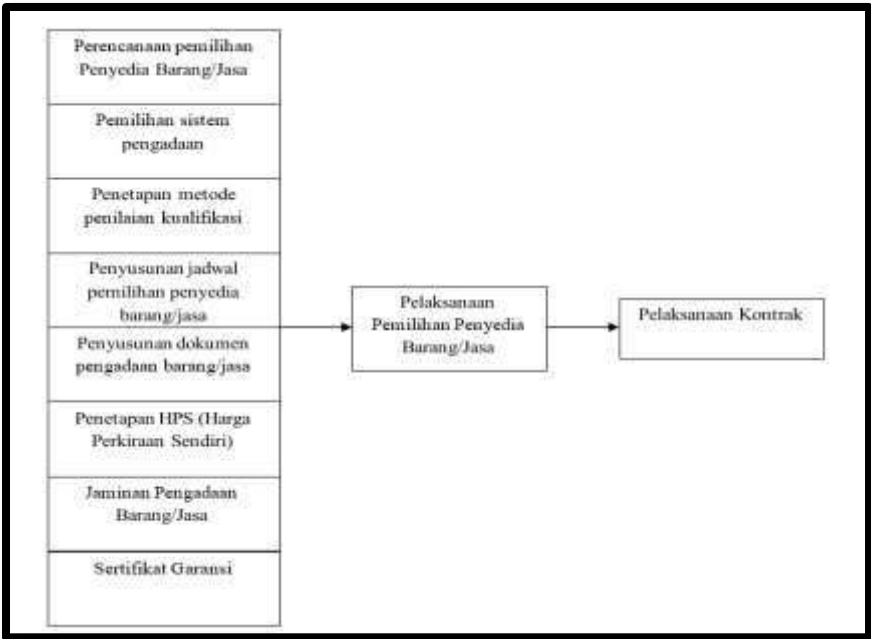
Waktu perencanaan dan penetapan kebutuhan yang meleset dari *timeline* yang telah dibuat sebelumnya akan mengakibatkan mundurnya waktu pelaksanaan dari proses – proses setelahnya. Hal ini dikarenakan proses perencanaan dan penetapan kebutuhan merupakan tahapan pertama dalam proses pengelolaan logistik di rumah sakit.

3.2.2 Pelaksanaan Pengadaan Logistik

Pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan beberapa cara, disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang ada, diantaranya adalah :

1. Pengadaan langsung : pengadaan langsung dilakukan oleh pengadaan PT yang membawahi RS Prima Husada. Pengadaan langsung dapat dilakukan jika besarnya pengadaan 1 – 50 juta.

- 2. Penunjukkan langsung : pengadaan langsung dilakukan oleh pengadaan PT yang membawahi RS Prima Husada. Penunjukkan langsung dapat dilakukan jika besarnya pengadaan 1 – 100 juta.
- 3. Pelelangan umum : pengadaan langsung dilakukan oleh pengadaan PT yang membawahi RS Prima Husada. Pelelangan umum dapat dilakukan jika besarnya pengadaan > 200 juta.

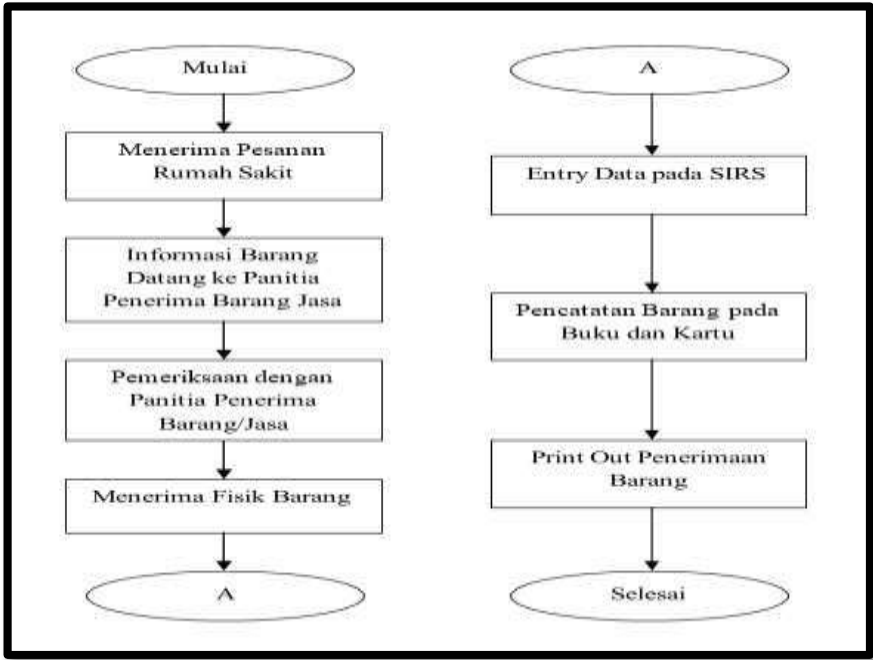


Gambar 4. Gambaran Umum Alur Pengadaan Barang/Jasa

Selain itu, untuk menunjang pengadaan agar dapat terlaksana baik dan tepat waktu, tidak hanya ketepatan dari setiap proses yang terdapat di pengadaan saja tetapi ketepatan dari mulai perencanaan juga akan berpengaruh dengan pengadaan. Karena bagaimanapun perencanaan merupakan proses pertama dalam siklus logistik di rumah sakit, jadi akan mempengaruhi proses selanjutnya.

3.2.3 Pelaksanaan Penyimpanan Logistik

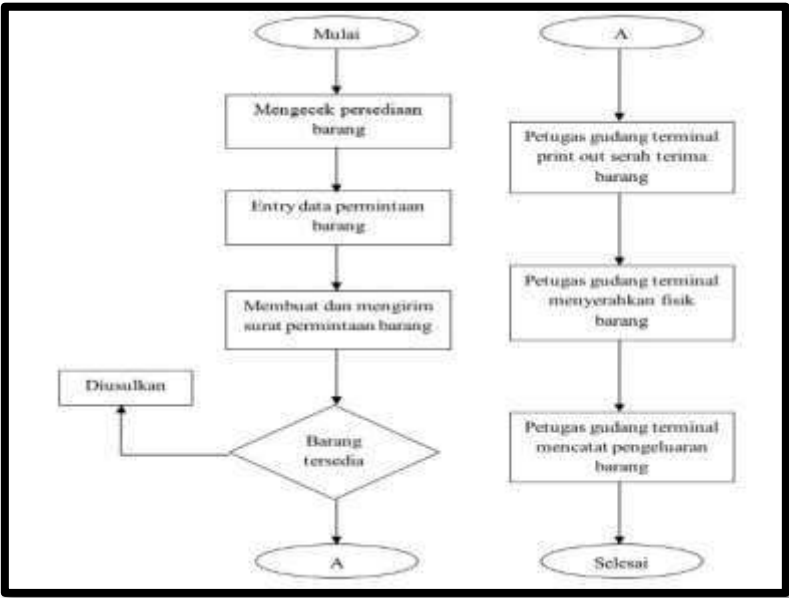
Penyimpanan barang dilakukan setelah terjadi proses penerimaan barang di gudang farmasi yang dilaksanakan oleh penerima barang dan disaksikan oleh petugas gudang. Penerima barang memeriksa, meneliti dan menghitung barang yang ada. Selain itu, pemeriksaan barang juga dilakukan dengan memeriksa kesesuaian antara barang yang diterima, baik dari nama, jumlah, kondisi, tanggal kadaluarsa dan spesifikasinya dengan yang tertera di dalam Surat Pengiriman Barang (SPB), Surat Pesanan dan faktur. Kemudian penerima barang menyerahkan barang dan dokumen yang telah diperiksa kepada petugas gudang farmasi. Petugas gudang farmasi selanjutnya akan memberikan cap stempel penerimaan barang dan menandatangani faktur sebagai bukti bahwa barang sudah diterima oleh gudang farmasi. Selanjutnya barang yang diterima, disimpan dalam gudang sesuai dengan kelompok barang dan/atau langsung didistribusikan ke depo farmasi.



Gambar 5. Alur Penerimaan Barang

3.2.4 Pelaksanaan Pendistribusian Logistik

Pelaksanaan pendistribusian barang di gudang farmasi dilakukan *double check* dengan petugas depo farmasi sesuai dengan SPO yang berlaku. Pendistribusian barang dari gudang farmasi ke depo farmasi tidak dapat dilakukan jika tidak disertai dengan kelengkapan surat, seperti list permintaan barang dan pengeluaran barang.



Gambar 6. Alur Pendistribusian Barang

3.2.5 Pelaksanaan Pemeliharaan Logistik

Kegiatan pemeliharaan barang di gudang farmasi Rumah Sakit Prima Husada bertujuan untuk mengamankan barang agar tidak rusak, hilang dan sebagainya selama penyimpanan, baik yang ditimbulkan karena proses kimia, alam dan *force major*. Setelah barang disimpan dan diperhatikan tanda-tanda yang ada pada kemasannya dan dilengkapi alat pengaman, kemudian petugas gudang farmasi merawat barang yang tersimpan dalam gudang setiap hari dengan cara dibersihkan dari debu dan dirapikan. Salah satu bentuk pemeliharaan yang dilakukan adalah

pencatatan kondisi suhu ruangan gudang farmasi dan kondisi suhu kulkas dan *vaccine refrigerator*. Kegiatan pencatatan suhu ini dilakukan oleh petugas gudang farmasi dua kali pagi dan sore. Sekalipun pemeliharaan barang di gudang farmasi telah dilakukan, namun tetap saja tidak luput dari masalah seperti kerusakan dan selisih perhitungan barang. Jika hal itu terjadi, maka petugas gudang wajib membuat laporan kerusakan ataupun berita acara selisih barang.

3.2.6 Penghapusan Logistik

Penarikan dan pemusnahan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai (BMHP), vaksin, reagen dan B3 yang rusak atau kadaluarsa harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar/ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM (*mandatory recall*) atau berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar (*voluntary recall*).

RS Prima Husada melakukan penghapusan logistik sendiri, terdiri dari beberapa cara yang dapat dilakukan, diantaranya adalah :

1. Dijual atau dilelang
Dengan cara ini berarti organisasi akan memperoleh sejumlah kontraprestasi berupa uang hasil penjualan logistik.
2. Ditukar dengan logistik lain yang dibutuhkan oleh institusi dengan cara ini organisasi akan menukarkan logistik yang dimiliki dengan logistik yang dibutuhkan oleh organisasi. Dengan cara ini harus mempertimbangkan dan mengacu pada prinsip-prinsip pengadaan logistik dengan cara menukarkan, antara lain logistik yang ditukarkan harus benar-benar sudah tidak dibutuhkan institusi, nilai logistik yang dipertukarkan harus sepadan dan saling menguntungkan kedua belah pihak.
3. Dipindahkan
Penghapusan dengan cara dipindahkan adalah secara fisik logistik yang sudah tidak dibutuhkan dimutasikan ke unit kerja lain ataupun kantor/ institusi cabang. Dengan demikian, pemusnahan logistik ini sifatnya masih dalam ruang lingkup organisasi internal
4. Dihilangkan
Penghapusan logistik dengan cara dihilangkan berarti organisasi memberikan secara cuma-cuma kepada pihak/organisasi lain yang membutuhkan logistik yang dihapuskan.
5. Pemanfaatan kembali
Penghapusan dengan cara pemanfaatan kembali berarti barang yang dihapus kemudian diubah menjadi barang lain yang memiliki fungsi dan kegunaan berbeda dari fungsi dan kegunaan barang semula.
6. Penghapusan
Penghapusan logistik dengan cara dimusnahkan adalah logistik benar-benar dihilangkan dan hal ini dilakukan apabila cara penghapusan logistik yang lain sudah tidak mungkin untuk diimplementasikan.

3.2.7 Pengendalian Logistik

Pengendalian yang terdapat di gudang farmasi Rumah Sakit Prima Husada berupa pencatatan, pembukuan dan pelaporan. Hal ini berlaku untuk semua jenis barang yang terdapat di gudang farmasi. Proses pencatatan dan pelaporan yang ada di gudang farmasi terdiri dari beberapa macam, disesuaikan dengan jenis kegiatan pencatatannya. Proses pencatatan yang terdapat di gudang farmasi dibagi menjadi dua, ada yang dilakukan secara online dengan SIMRS dan ada juga yang dilakukan secara manual. Keduanya dilakukan untuk saling menunjang satu sama lainnya. Pencatatan dilakukan berkaitan dengan barang, dari mulai barang masuk atau diterima di gudang sampai barang tersebut keluar dari gudang farmasi. Pada

dasarnya semua proses pencatatan yang dilakukan bertujuan untuk menyajikan data dan informasi barang, serta mempermudah pengawasan.

3.3 Faktor Output

Koordinasi dari unsur-unsur pada *input* dan proses yang terdapat pada sistem logistik di rumah sakit akan menghasilkan suatu *output*. *Output* dari sistem logistik yang dimaksud disini adalah ketersediaan barang di gudang farmasi RS Prima Husada. Ketersediaan yang baik jika jumlah dari tiap jenis barang yang ada di gudang farmasi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan permintaan dari seluruh unit yang ada di rumah sakit serta jumlah tersebut juga meliputi *safety stock* sebesar 10-20% sebagai cadangan atau pengaman ketika permintaan terhadap suatu barang melebihi dari jumlah biasanya.

Ketersediaan barang di gudang farmasi, jumlahnya dapat dilihat di dalam pencatatan dan pembukuan yang dilakukan oleh petugas gudang setiap ada penerimaan maupun pengeluaran. Untuk mengetahui sisa jumlah barang yang tersedia dapat dilihat di kartu stok yang terdapat di dalam gudang, laporan *stock opname*, maupun data SIMRS yang menggambarkan jumlah barang yang keluar dan masuk, *warning* barang akan habis, serta sisa stock terakhir dari setiap jenis barang.

Ketersediaan barang di gudang farmasi selalu diusahakan dalam keadaan cukup. Tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan para *user*, tetapi juga cukup sebagai stok simpanan atau cadangan yang digunakan untuk keperluan diluar perkiraan dari kebutuhan biasanya. Namun, dengan demikian bukan berarti ketersediaan barang di gudang farmasi tidak mengalami masalah. Masalah yang biasanya terjadi yang berhubungan dengan ketersediaan barang di gudang farmasi adalah kekosongan barang (*stockout*) atau kebalikannya, penumpukan barang (*overstock*).

Kekosongan barang yang terjadi di gudang farmasi terjadi pada waktu yang tidak dapat ditentukan. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kekosongan tersebut. Namun, kekosongan barang di gudang farmasi ternyata juga terjadi secara berkala tiap tahunnya pada periode waktu tertentu. Bahkan hal tersebut sudah terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini. Kekosongan yang sifatnya tidak menentu biasanya terjadi karena ada lonjakan permintaan akibat peningkatan kebutuhan yang dapat disebabkan oleh banyak hal, misalnya seperti terjadi wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk obat – obatan dan perhitungan kebutuhan yang kurang tepat. Untuk kekosongan barang yang terjadi secara berkala, biasanya terjadi karena kekosongan pada distributor atau kekosongan pabrik.

Sementara itu, untuk masalah penumpukan barang yang terjadi di gudang tidak berbeda jauh dengan masalah kekosongan barang. Penumpukan barang dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah perencanaan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ketersediaan barang di depo farmasi disesuaikan dengan kebutuhan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Biasanya didasari oleh jumlah kebutuhan dan ditambah dengan *safety stock*. Namun, masalah seputar ketersediaan barang di gudang farmasi tetap saja terjadi. Masalah seperti kekosongan, selisih perhitungan dan penumpukan pada waktu tertentu biasa terjadi di gudang farmasi. Ketersediaan barang merupakan *output* utama dalam suatu sistem logistik di rumah sakit. Di gudang farmasi Rumah Sakit Prima Husada, ketersediaan juga selalu dijaga agar tetap dalam jumlah yang efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan para *user*.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

4.1 Monitoring

1. Unsur-unsur yang terdapat dalam input yang mempengaruhi proses pengelolaan dan *output* logistik di gudang farmasi Rumah Sakit Prima Husada diantaranya adalah SDM, fasilitas, mesin, dana, prosedur, struktur dan *supplier*.
2. Unsur-unsur yang terdapat dalam proses yang mempengaruhi *output* dari sistem logistik di Rumah Sakit Prima Husada terdiri dari proses perencanaan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan pengendalian.
3. Dari beberapa unsur tersebut, masalah yang terdapat pada proses perencanaan dan penetapan kebutuhan terkait waktu dan pelaksanaannya, masalah penyimpanan terkait dengan sistem penyimpanan yang masih sederhana dan kerusakan barang selama penyimpanan, serta masalah pengendalian yang digunakan oleh gudang farmasi yang masih sederhana merupakan masalah yang cukup dominan di gudang farmasi.
4. Ketersediaan barang di gudang farmasi meliputi sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, vaksin, reagen, gas medis, bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan output dari sistem logistik di Rumah sakit Prima Husada. Masalah yang terkait dengan ketersediaan barang di gudang farmasi adalah kekosongan (*stockout*) dan penumpukan (*overstock*).

4.2 Evaluasi

1. Memberikan pelatihan internal atau eksternal mengenai manajemen logistik agar SDM mempunyai bekal pengetahuan mengenai logistik.
2. Dalam melakukan perencanaan dan penetapan kebutuhan diusahakan agar dilakukan tidak hanya berdasarkan konsumsi tahun sebelumnya dan juga perkiraan penggunaan dari masing – masing *user*.
3. Mengusahakan agar pelaksanaan perencanaan dan penetapan kebutuhan dilakukan sesuai dengan waktu dalam *timeline*, sehingga pemenuhan barang persediaan di gudang dapat dilakukan tepat waktu.
4. Menerapkan sistem pengendalian yang lebih terpadu sehingga *output* yang dihasilkan menjadi lebih baik, khususnya pengendalian terhadap persediaan.

BAB V

PENUTUP

Buku panduan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi apoteker dan tenaga vokasi farmasi yang bekerja di rumah sakit dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, vaksin, reagen, gas medis, bahan berbahaya dan beracun (B3). Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik yang baik ,efektif, dan efisien akan mendorong penggunaan obat yang rasional di rumah sakit. Manajemen logistik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya pengobatan dan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit.

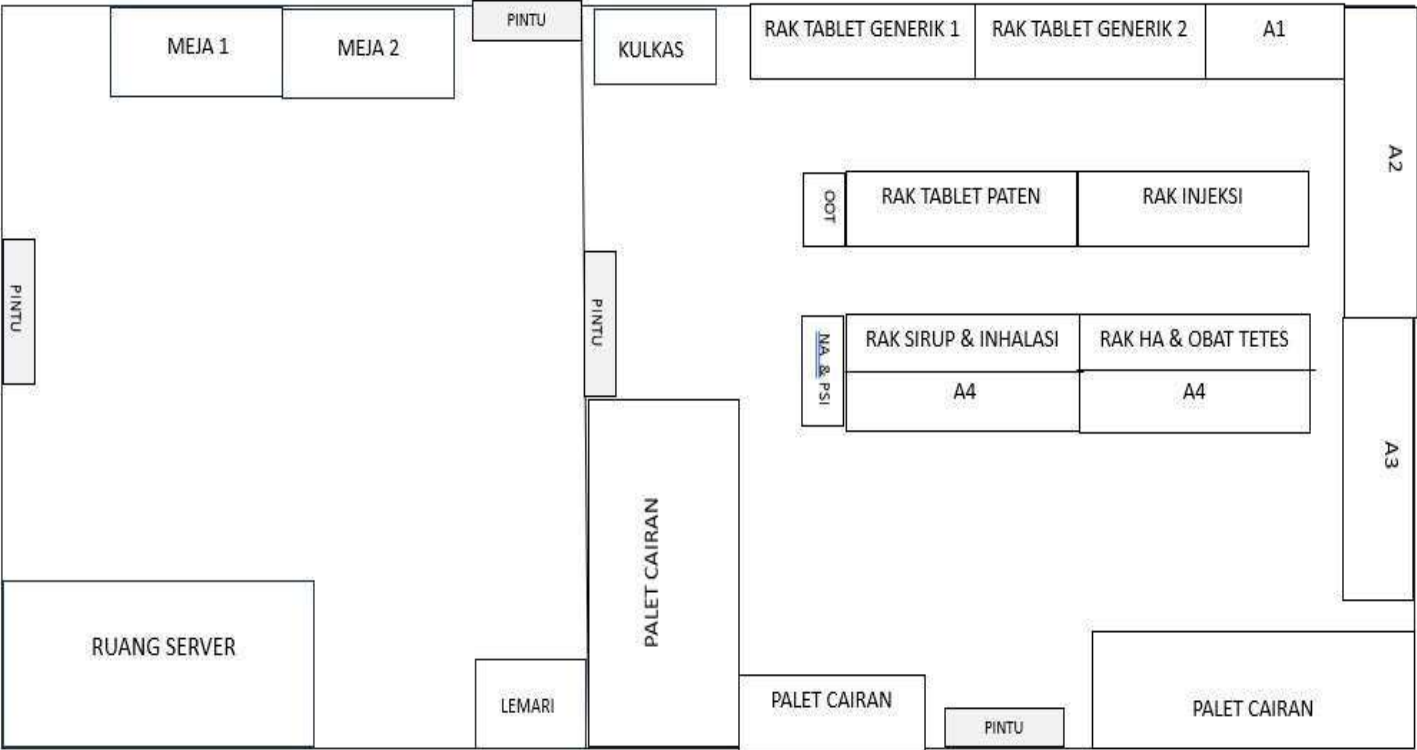
Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 02 Februari 2026
Direktur Rumah Sakit PrimaHusada,



Ns. Heni Indra Wulansari, S. Kep. M. Kep

Lampiran

Denah penyimpanan barang di Gudang Farmasi
Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo



Daftar Pustaka

- Aditama. (2012). *Manajemen Administrasi rumah sakit*. Edisi 2. Jakarta. UI Press.
- Asosiasi Logistik Indonesia (2011). *Panduan dan Direktori Logistik Indonesia*. Cetakan Pertama. Penerbit PPM, Jakarta.
- Dwiwanty Grestar. (2018). *Efektivitas Sistem E-Procurement Dalam Pelelangan Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Garcia, M., Hernandez. G., & Hernandez, J. (2013). *Enterprise logistics; indicators and physical distribution manager*. Research in logistics & production 3 (1), 5-20.
- Gattorna, JL dan DW. Walters. 2011. *Managing the Supply Chain. A strategic Perspective*. McMillan Press Ltd London.
- Hendayani, R. 2011. *Mari Berkenalan dengan Manajemen Logistik*. Cetakan Pertama. Bandung: Alfabeta.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Rahmiyati, A. L, & Irianto, G. (2021). *Teori dan praktik manajemen logistik rumah sakit*. PT. Refika Aditama.
- Ratnasari, S. L. (2019). *Human Capital Manajemen SUMBER Daya Manusia*. Surabaya: CV Penerbit Qiara Me.